



PCMSO

Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional

**SPE R70 EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA**

22/09/2026

Versão: 1

Índice

2 - CONTROLE DE REVISÃO DO PCMSO	4
3 - NORMA REGULAMENTADORA - NR7	5
4 - OBJETIVO	5
5 - DIRETRIZES	6
6 - PLANEJAMENTO	7
7 - DESENVOLVIMENTO	8
8 - RESPONSABILIDADES	8
9. EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	9
9.3.1 - QUADRO 1 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO EXCESSIVA	12
9.3.2 - QUADRO 2 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO COM SIGNIFICADO CLÍNICO	17
9.5 - EXAME RADIOLÓGICO	29
9.6 - EXAME ESPIROMÉTRICO	33
9.7 - GESTANTES/ LACTANTES	33
9.8 - MANIPULADORES DE ALIMENTO	34
9.9 - EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO CALOR E ACLIMATIZAÇÃO	34
9.10 - RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO	38
10 - DOCUMENTOS	39
Unidade: SPE R70	41
Setor: GHE 01 - BETONEIRA	41
Cargo: Operador de Betoneira	42
Setor: GHE 02 - ARMAÇÃO	42
Cargo: Encarregado de Armação	44
Setor: GHE 03 - CARPINTARIA	44
Cargo: Meio oficial de carpinteiro	45
Setor: GHE 04 - PRODUÇÃO 01	45
Cargo: Servente	47
Setor: GHE 05 - LIMPEZA	47
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	48
Setor: GHE 06 - CREMALHEIRA	48
Cargo: Operador de elevador tipo cremalheira	49
Setor: GHE 07 - SEGURANÇA DO TRABALHO	49
Cargo: Técnico em Segurança Do Trabalho	50
Setor: GHE 08 - SUPERVISÃO DE EQUIPES	50
Cargo: Mestre de obras	52
Setor: GHE 09 - ADMINISTRAÇÃO	52
Cargo: Jovem aprendiz	53
Setor: GHE 10 - ALMOXARIFADO	53
Cargo: Auxiliar de Almoxarife	54
Setor: GHE 11 - ENGENHARIA	54
Cargo: Estagiário de Engenharia Civil	55
Setor: GHE 12 - MAQUINAS	55
Cargo: Operador de maquinas	56
Setor: GHE 13 - PORTARIA	56
Cargo: Porteiro	57
Setor: GHE 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DESENERGIZADO	57
Cargo: Meio Oficial de Eletricista	58
Setor: GHE 16 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	58
Cargo: Meio Oficial de Encanador	60
Setor: GHE 17 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESENERGIZADO)	60
Cargo: Eletricista manutenção	61
Setor: GHE 18 - ADMINISTRAÇÃO 02	61
Cargo: Menor aprendiz	61
Setor: GHE 19 - ADMINISTRAÇÃO 03	61
Cargo: Recepcionista	62
Setor: GHE 20 - OPERAÇÃO DE GRUA	62
Cargo: Operador de grua	63
Setor: GHE 21 - LIMPEZA INTERNA	63
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais	64
Setor: GHE 22 - SERRALHERIA	64
11. PROGRAMA DE VACINAÇÃO	66
SALAS DE VACINAS	67
SALAS DE VACINAS	71
12 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM SAÚDE PREVENTIVA	74
13. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	76
13.1 - AÇÕES DO PROGRAMA (CRONOGRAMA)	76
13.2 - PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES	77
14. SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA	78
15. TERMO DE COMPROMISSO	79
16. ANEXOS	80

16.1 - ANEXOS.....	81
16.2 - ANEXOS.....	82
16.3 - ANEXOS.....	83
16.4 - ANEXOS.....	89



	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	22/09/2026
---	---	--

Identificação			
Empresa SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA			
Endereço Rua 4, 1400		Complemento Quadra73 Lote Area Total	CNPJ 41.593.197/0001-05
CEP 74025-020	Cidade Goiânia	Bairro Setor Central	UF GO
CNAE 41.10-7	Grau de Risco 3	Descrição CNAE Incorporação de empreendimentos imobiliários	

2 - CONTROLE DE REVISÃO DO PCMSO

Data	Revisão	Considerações sobre a revisão
28/07/2026	01	Inclusão dos riscos psicossociais
22/09/2026	02	Adequação dos exames para o novo protocolo de avaliação dos riscos psicossociais

3 - NORMA REGULAMENTADORA - NR7

O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) visa atender o disposto na Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, e Normas Regulamentadoras, especificamente a NR-7, de 08/06/1978, com modificações do texto através de portarias anteriores.

A NR-07 foi revisada em março de 2020 e entrou em vigor dia 03/01/2022 (Portaria nº 6.734, de 2020 (DOU 13/03/2020). A Portaria MTP Nº567, de 10 de março de 2022 (DOU em 01/04/2022) altera a nova NR-07 acima citada. O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, resolve: Art. 1º A Norma Regulamentadora nº07 (NR-07) - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, aprovada pela Portaria SEPRT/ME nº 6.734, de 9 de março de 2020, publicada no DOU de 13/03/2020 - Seção 1, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo desta Portaria. Art.2º Esta Portaria entrou em vigor 60 dias após a publicação.

A NR-7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do PCMSO. Estabelece, ainda, os parâmetros e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO.

4 - OBJETIVO

Esta Norma Regulamentadora - NR-07- estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização (empresa).

O PGR deve acompanhar continuamente as atividades da empresa por meio da execução das medidas previstas no plano de ação. Inclusive, deve refletir eventuais mudanças no ambiente de trabalho que alterem as características dos riscos ocupacionais.

A avaliação de riscos do PGR - que é uma das etapas desse programa - deve ser revista no máximo a cada dois anos. No caso de organizações que possuam certificações em sistema de gestão de SST, esse prazo pode ser de até três anos.

Segundo a NR-01, a avaliação de riscos deve ser alterada ou revista quando da ocorrência das hipóteses descritas no item 1.5.4.4.6:

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

- a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
- b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
- e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

O PCMSO deve ser revisado caso houver revisão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) ou AET (Análise Ergonômica do Trabalho), ao detectar mudanças nos riscos ocupacionais passíveis de controle biológico, convenção coletiva do trabalho ou por determinação legal ou de órgão fiscalizador ou quando de sua revisão.

Alterações também podem surgir quando o médico detectar novas descobertas da ciência médica, em relação a efeitos de riscos existentes; mudança de critérios de interpretação dos exames.

Deve haver a correlação do PCMSO com o ambiente de Trabalho, guardando a estreita relação com as características do ambiente e com os riscos inerentes à natureza e à organização do trabalho.

O PCMSO visa o monitoramento biológico da exposição ocupacional dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos, contribuindo positivamente nos seguintes pontos:

- Diminuição do absenteísmo por motivos médicos ocupacionais;
- Melhoria na produtividade;
- Melhoria na qualidade de vida no trabalho;
- Melhoria das relações do trabalho;
- Aumento do comprometimento e satisfação dos colaboradores com a empresa.

5 - DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa harmonizado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, principalmente com a NR-1, NR-9, NR-17 e NR-18.

São diretrizes do PCMSO:

- a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na empresa;
- e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) subsidiar o encaminhamento dos empregados à Previdência Social;
- i) acompanhar de forma diferenciada os empregados, cujos estados de saúde possam ser especialmente afetados pelos riscos ocupacionais;
- j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- k) subsidiar ações de readaptação profissional;
- l) monitorar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de:

- a) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos;
- b) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

O PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal.

Obs: A responsabilidade técnica- médica pelo PCMSO tem a vigência do período contratual com o Seconci-GO, em caso de não renovação do contrato ou cancelamento do mesmo, a responsabilidade técnica cessa a partir da data desta rescisão

6 - PLANEJAMENTO

O PCMSO deve ser elaborado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.

Este Documento Base será atualizado anualmente e/ou todas as vezes que se fizer necessário devido a alterações Programa de Gerenciamento de Risco da organização (empresa).

O PGR deve acompanhar continuamente as atividades da empresa por meio da execução das medidas previstas no plano de ação. Inclusive, deve refletir eventuais mudanças no ambiente de trabalho que alterem as características dos riscos ocupacionais.

A avaliação de riscos do PGR - que é uma das etapas desse programa - deve ser revista no máximo a cada dois anos. No caso de organizações que possuam certificações em sistema de gestão de SST, esse prazo pode ser de até três anos.

Portanto, qualquer alteração ocorrida no PGR/PCMAT, o médico responsável pelo PCMSO deverá ser comunicado, formalmente, para as devidas adequações no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

São considerados riscos ocupacionais para fins de monitoramento biológico e vigilância à saúde (e, portanto, constar em ASO), os agentes químicos, reconhecido no PGR, que quantitativamente estão acima do nível de ação determinados na NR-09, ou o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas ou se a classificação de riscos do PGR indicar a exigência de monitoramento.

Exceção aos riscos de poeiras, no qual, seguiremos, conforme anexo III da NR-07. Assim também, para os agentes químicos cancerígenos, conforme informado no PGR da organização, serão obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 10% (dez por cento) dos limites de exposição ocupacional, ou quando não houver avaliação ambiental e devem ser executados e interpretados com base nos critérios constantes na NR-07.

Os agentes que não possuem limites de tolerância, ou seja, que não possuem concentração ou intensidade máxima ou mínima identificada como segura, capaz de causar danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral, devem determinar monitoramento biológico e vigilância à saúde sempre que reconhecidos.

O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

A empresa deve garantir que o PCMSO:

- a) Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
- b) Contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos da NR 7;
- c) Contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos. Anexos:

- **11.2 Fluxo Geral de Sugestão de Condutas em Medicina do Trabalho;**
- **11.3 Fluxo Específico para Alterações nos Exames Complementares para Monitorização Biológica dos Agentes Químicos no Anexo I (Quadro 1 E 2 da NR-7);**
- **11.4 Fluxo Específico para Alterações nos demais exames complementares.**

- d) Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados: treinamento para conhecimento dos fluxos supracitados, com registro no RQ_08_LISTA DE PRESENÇA/TREINAMENTO/PALESTRA/CURSO;
- e) Inclua Relatório Analítico sobre o desenvolvimento do programa;

O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da empresa, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR. **Esta sinalização procederá através da comunicação do Departamento de Assessoria em Saúde, via e-mail, com o elaborador e/ou empresa responsável pelo PGR.**

7 - DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento PCMSO deverá incluir a realização de exames médicos ocupacionais que incluem a avaliação clínica constituída pela anamnese ocupacional, exame físico e mental, bem como a realização de exames complementares conforme o risco ocupacional a que o trabalhador estiver exposto.

8 - RESPONSABILIDADES

1. Da empresa:

- Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
- Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

2. Do Médico Responsável pelo PCMSO

- a) Elaborar e implementar o PCMSO, visando a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores;
- b) Planejar, analisar, controlar e acompanhar o desenvolvimento e execução do PCMSO e seus resultados;
- c) Elaborar o Relatório Analítico do PCMSO;
- d) Realizar os exames médicos previstos no PCMSO ou encarregar a realização dos mesmos aos médicos examinadores;
- e) Gerenciar os casos que apresentem algum comprometimento da saúde relacionado ao trabalho ou não, decorrente dos exames médicos e/ou complementares;
- f) Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- g) Informar à empresa, constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da NR-07. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.
- h) Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO.

- i) Avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.
- J) Prestar esclarecimentos, quando solicitado sobre os problemas de saúde ocupacional, respeitando o princípio ético do sigilo médico.
- k) Discutir conjuntamente com os profissionais da área de Segurança do Trabalho e/ ou Meio Ambiente, medidas preventivas quanto à melhoria do ambiente de trabalho, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa.

3. Do Médico Examinador

- a) Executar os exames médicos: admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissionais, examinando os trabalhadores, avaliando os resultados dos exames complementares, informando aos mesmos os resultados dos exames;
- b) Comunicar o Médico Responsável pelo PCMSO e ao empregado, sempre que necessário, ao constatar uma ocorrência ou agravamento de doenças do trabalho ou ocupacionais, através de exames médicos, ou ao verificar as alterações que revelem qualquer tipo de disfunção;
- c) Indicar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho;
- d) Quando orientado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexos causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho.

4. Do Empregado

- a) Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- b) Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
- c) Utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido pela empresa;
- d) Cumprir as disposições legais e regulamentos sobre segurança, saúde e meio ambiente, inclusive as ordens de serviço expedidas pela empresa;
- e) Comunicar imediatamente, ao médico responsável pelo PCMSO ou médico examinador, quando acometido por problemas de saúde.

9. EXAME MÉDICO OCUPACIONAL

9.1 - Atestado de Saúde Ocupacional - ASO

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá o ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

O médico examinador emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em três vias:

1. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da Fiscalização do Trabalho;
2. A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via;
3. A terceira via do ASO ficará arquivada no SECONCI-GO, dentro do prontuário médico do paciente.

O ASO deve conter no mínimo:

- a) Razão social e CNPJ da empresa;
- b) Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- c) Descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;

- d) Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO;
- g) Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

A aptidão para trabalho em atividades específicas (trabalho em altura e trabalho em espaço confinado), quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

9.2 - Exames Médicos Ocupacionais

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos, os quais compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta norma e de outras NR:

- a) Admissional;
- b) Periódico;
- c) Retorno ao trabalho;
- d) Mudança de Riscos Ocupacionais;
- e) Demissional.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

I - Exame Admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;

II - Exame Periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

- Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos: a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
- Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

Os exames periódicos que apresentarem alguma alteração terão novas orientações com periodicidade, acréscimo ou repetições de exames complementares a critério do Médico Responsável pelo PCMSO.

III. No Exame de Retorno ao Trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

IV. O Exame de Mudança de Risco Ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

VI. No Exame Demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

9.3 - Periodicidade dos Exames Laboratoriais

Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/ANVISA n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos da Norma, NR-07, e são obrigatórios quando:

- a) o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

Observações:

- O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR.
- Quando a empresa realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado.
- Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.
- Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.
- Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.
- Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.
- A monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos, a níveis de pressão sonora elevados e a substâncias cancerígenas e radiações ionizantes ficará a critério do PGR da empresa.
- No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.
- Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- Quando constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

- a) Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) Afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
- c) Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/ANVISA n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos da Norma, NR-07, e são obrigatórios quando:
- d) Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.
- e) Orientar o Diretor da Empresa quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho.

Observações:

- O empregado, em uma das situações previstas acima, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias.
- O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

9.3.1 – QUADRO 1 DO ANEXO I NR-7 – INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO EXCESSIVA

A meia-vida de uma substância ou de seu metabólito determina o momento em que deve ser realizada a coleta da amostra de material biológico para análise.

A meia-vida da maioria das substâncias do quadro I da NR-7 é curta ou muito curta e como existe a necessidade de um período entre o início da exposição ao agente químico e a possibilidade de se utilizar a dosagem biológica como indicador, o monitoramento da exposição a tais substâncias pode ser utilizada como indicador após 06 meses de exposição.

A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser realizada semestralmente (Exame Periódico).

Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção. Esta sinalização procederá através da comunicação do Departamento de Assessoria em Saúde, via e-mail, com o elaborador e/ou empresa responsável pelo PGR.

O empregado exposto a esta condição, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

ANEXO I MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGENTES QUÍMICOS

(Alterado pela Portaria MTP nº 567, de 10 de março de 2022)

Substância	Número CAS	Indicador(es)	Momento da Coleta	Valor do IBE/EE	Observações
1,1,1 Tricloroetano	71-55-6	1,1,1 Tricloroetano no ar exalado final ou	AJFS	40 ppm	-
		Ácido tricloroacético na urina ou	FJFS	10 mg/L	NE
		Tricloroetanol total na urina ou	FJFS	30 mg/L	NE
		Tricloroetanol total no sangue	FJFS	1 mg/L	NE
1,3 butadieno	106-99-0	1,2 dihidro-4 (nacetilcisteína) butano na urina	FJ	2,5 mg/L	EPNE
1,6 diisocianato de hexametileno (HDI)	822-06-0	1,6 hexametilenodiamina na urina	FJ	15 µg/g creat.	NE
2-butoxietanol	111-76-2	Ácido butoixiacético na urina (BAA) (H)	FJ	200 mg/g creat.	-
2-metoxietanol e	109-86-4	Ácido 2-metóxiacético na urina	FJFS	1 mg/g creat.	-
2 - metoxietilacetato	109-49-6				
2-propanol	67-63-0	Acetona na urina	FJFS	40 mg/L	EPNE, NE
2,4 e 2,6 Tolueno diisocianato	58484-9	Isômeros 2,4 e 2,6 toluenodiamino na urina ^(H) (soma dos isômeros)	FJ	5 µg/g creat.	NE
(puros ou em mistura dos dois isômeros)	9108-7				

ANEXO I MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGENTES QUÍMICOS

Acetona	67-64-1	Acetona na urina	FJ	25 mg/L	NE
Anilina	62-53-3	p-amino-fenol na urina(H) ou	FJ	50 mg/L	EPNE, NE
		metahemoglobina no sangue	FJ	1,5% da hemoglobina	EPNE, NE
Arsênico elementar e seus compostos inorgânicos solúveis, exceto arsina e arsenato de gálio	7440-38-2	Arsênico inorgânico mais metabólitos metilados na urina	FS	35 µg/L	EPNE
Benzeno	71-43-2	Ácido s- fenilmercaptúrico (S- PMA) na urina ou	FJ	45 µg/g creat.	EPNE, NF
		Ácido trans- transmucônico (TTMA) na urina	FJ	750 µg/g creat.	EPNE, NE
				Observação:	
				para a	
Chumbo tetraetila	78-00-2	Chumbo na urina	FJ	siderurgia será mantida a regra	-
				atualmente vigente.	

ANEXO I MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGENTES QUÍMICOS

Ciclohexanona	108-94-1	1,2 ciclohexanodiol ^(H) na urina ou	FJFS	80 mg/L	NE
		Ciclohexanol ^(H) na urina	FJ	8 mg/L	NE
Clorobenzeno	108-90-7	4clorocatecol ^(H) na urina ou	FJFS	100 mg/g creat.	NE
		p-clorofenol ^(H) na urina	FJFS	20 mg/g creat.	NE
Cobalto e seus compostos inorgânicos, incluindo óxidos de cobalto, mas não combinados com carbeto de tungstênio	7440-48-4	Cobalto na urina	FJFS	15 µg/L	NE
Cromo hexavalente (compostos solúveis)	7440-47-3	Cromo na urina ou	FJFS	25 µg/L	-
		Cromo na urina	AJ-FJ (Aumento durante a Jornada)	10 µg/L	-
Diclorometano	75-09-2	Diclorometano na urina	FJ	0,3 mg/L	-
Estireno	100-42-5	Soma dos ácidos mandélico e fenilgloxílico na urina ou	FJ	400 mg/g creat.	NE
		Estireno na urina	FJ	40 µg/L	-
Etilbenzeno	100-41-4	Soma dos ácidos mandélico e fenilgloxílico na urina	FJ	0,15 g/g creat.	NE

ANEXO I MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGENTES QUÍMICOS

Etoxi-etanol e Etoxi-etilacetato	1. 111-15-9	Ácido etoxiacético na urina	FJFS	100 mg/g creat.	-
Fenol	108-95-2	Fenol ^(H) na urina	FJ	250 mg/g creat.	EPNE, NE
Furfural	98-01-1	Ácido furóico ^(H) na urina	FJ	200 mg/L	NE
Indutores de Metahemoglobina		Metahemoglobina no sangue	FJ	1,5% da hemoglobina	EPNE, NE
Mercúrio metálico	7439-97-6	Mercúrio na urina	AJ	20 µg/g creat.	EPNE
Metanol	67-56-1	Metanol na urina	FJ	15 mg/L	EPNE, NE
Metil-butil-cetona	591-78-6	2,5 hexanodiona ^(SH) (2,5H D) na urina	FJFS	0,4 mg/L	-
Metiletilcetona (MEK)	78-93-3	MEK na urina	FJ	2 mg/L	NE
Metilisobutilcetona (MIBK)	108-10-1	MIBK na urina	FJ	1 mg/L	-
Monóxido de carbono	630-08-0	Carboxihemoglobina no sangue ou	FJ	3,5% da hemoglobina	EPNE, NE, NF
		Monóxido de carbono no ar exalado final	FJ	20 ppm	EPNE, NE, NF
n-hexano	110-54-3	2,5 hexanodiona ^(SH) (2,5H D) na urina	FJ	0,5 mg/L	-

ANEXO I MONITORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGENTES QUÍMICOS

Nitrobenzeno	98-95-3	Metahemoglobina no sangue	FJ	1,5% da hemoglobina	EPNE, NE
N-metil-2-pirrolidona	872-50-4	5-hidroxi-n-metil-2- pirrolidona ^(SM) na urina	FJ	100 mg/L	-
N,N Dimetilacetamida	127-19-5	Nmetilacetamida na urina	FJFS	30 mg/g creat.	-
N,N Dimetilformamida	68-12-2	Nmetilformamida total ¹ na urina ¹ (soma da N- metilformamida e N-(hidroximetil)-N- metilformamida) ou	FJ	30 mg/L	-
		N-Acetil-S-(N- metilcarbemoil) cisteína na urina	FJFS	30 mg/L	-
Óxido de etileno	75-21-8	Adutos de N-(2- hidroxietil) valina (HEV) em hemoglobina	NC	5.000 pmol/g hemog.	NE
Sulfeto de carbono	75-15-0	Ácido 2-tioxotiazolidina 4 carboxílico (TTCA) na urina	FJ	0,5 mg/g creat.	EPNE, NE
Tetracloroetileno	127-18-4	Tetracloroetileno no ar exalado final ou	AJ	3 ppm	-
		Tetracloroetileno no sangue	AJ	0,5 mg/L	-
Tetrahidrofurano	109-99-9	Tetrahidrofurano na Urina	FJ	2 mg/L	-
Tolueno	108-88-3	Tolueno no sangue ou	AJFS	0,02 mg/L	-
		Tolueno na urina ou	FJ	0,03 mg/L	-
		Orto-cresol na urina(H)	FJ	0,3 mg/g creat.	EPNE
Tricloroetileno	79-01-6	Ácido tricloroacético na urina ou	FJFS	15 mg/L	NE
		Tricloroetanol no sangue(SH)	FJFS	0,5 mg/L	NE
Xilenos	9547-6	Ácido metilhipúrico na urina	FJ	1,5 g/g creat.	-
	10642-3				
	10838-3				
	1330-27-7				

*São indicadores de exposição excessiva (EE) aqueles que não têm caráter diagnóstico ou significado clínico. Avaliam a absorção dos agentes por todas as vias de exposição e indicam, quando alterados, após descartadas outras causas não ocupacionais que justifiquem o achado, a possibilidade de exposição acima dos limites de exposição ocupacional. As amostras devem ser colhidas nas jornadas de trabalho em que o trabalhador efetivamente estiver exposto ao agente a ser monitorado.

9.3.2 - QUADRO 2 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO COM SIGNIFICADO CLÍNICO

O monitoramento biológico das substâncias com meia-vida prolongada, deverá ser realizado no Exame Admissional, no Exame Periódico (semestralmente), Mudança de Riscos Ocupacionais, Retorno ao Trabalho, e no Exame Demissional.

Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

- a) emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
- c) encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
- d) reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

QUADRO 2 - Indicadores Biológicos de Exposição com Significado Clínico (IBE/SC) *

(Alterado pela Portaria MTP nº 567, de 10 de março de 2022)

Substância	Número CAS	Indicador	Coleta	Valor do IBE/SC	Observações
Cádmio e seus compostos inorgânicos	7440-43-9	Cádmio na urina	NC	5 µg/g creat.	-
Chumbo e seus compostos inorgânicos	7439-92-1	Chumbo no sangue (Pb-S) eC	NC	60 µg/100ml ^(M)	EPNE
		Ácido Delta Amino Levulínico na urina (ALA-U)	NC	10 mg/g creat.	EPNE, PNE
Inseticidas inibidores da Colinesterase		Atividade acetilcolinesteras e eritrocitária ou	FJ	70% da atividade basal (#)	NE
		Atividade butilcolinesterase plasma ou soro	FJ	60% da atividade basal (#)	NE
Flúor, ácido fluorídrico e fluoretos inorgânicos		Fluoreto urinário	AJ48	2 mg/L	EPNE

(*) Indicadores biológicos com significado clínico (SC) evidenciam disfunções orgânicas e efeitos adversos à saúde.

(#) A atividade basal é a atividade enzimática pré-ocupacional e deve ser estabelecida com o empregado afastado por pelo menos 30 (trinta) dias da exposição a inseticidas inibidores da colinesterase.

(M) Mulheres em idade fértil, com valores de Chumbo no sangue (Pb-S) a partir de 30 µg/100ml, devem ser afastadas da exposição ao agente.

Abreviaturas

IBE/EE - Indicadores Biológicos de Exposição Excessiva

IBE/SC - Indicadores Biológicos de Exposição com Significado Clínico µg/g creat. - Microgramas por grama de creatinina µg/L - Microgramas por litro

AJ - Antes da Jornada

AJ-FJ - Diferença pré e pós-jornada

AJ48 - Antes da jornada com no mínimo 48 horas sem exposição

AJFS - Início da última jornada de trabalho da semana

EPNE - Encontrado em populações não expostas ocupacionalmente

FJ - Final de jornada de trabalho

FJFS - Final do último dia de jornada da semana

FS - Após 4 ou 5 jornadas de trabalho consecutivas

H - Método analítico exige hidrólise para este IBE/EE

SH - O método analítico deve ser realizado sem hidrólise para este IBE/EE mg/L - Miligramas por litro

NC - Não crítica (pode ser colhido a qualquer momento desde que o trabalhador esteja trabalhando nas últimas semanas)

NE - Não específico (pode ser encontrado por exposições a outras substâncias)

NF - Valores para não fumantes (fumantes apresentam valores basais elevados deste indicador que inviabilizam a interpretação)

pmol/g hemog - Picomoles por grama de hemoglobina

ppm - Partes por milhão" (NR)

9.3.3 Periodicidade dos Exames Laboratoriais para Exposição à Benzeno

As ações de vigilância da saúde dos empregados expostos a benzeno devem seguir o disposto na Instrução Normativa Nº 2, de 20 de dezembro de 1995, da SSST/Ministério do Trabalho, e na Portaria de Consolidação Nº 5, Anexos LXVIII, LXIX, LXX e LXXI, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.

Será solicitado exame complementar, com sua devida periodicidade, presente no quadro I da NR-07 e para os colaboradores expostos a benzeno, precisamente, os que manipulam combustíveis (gasolina, diesel, etc.), os exames de Hemograma Completo e Contagem de Reticulócitos serão realizados no Exame Admissional, Exame Periódico semestral e no Exame Demissional.

9.3.4 Substâncias Químicas Cancerígenas

Deve-se estabelecer diretrizes e parâmetros complementares no PCMSO para vigilância da saúde dos empregados expostos ocupacionalmente a substâncias químicas cancerígenas e a radiações ionizantes, de acordo com as informações fornecidas pelo Programa de Gerenciamento de Risco - PGR, visando à prevenção e à detecção do câncer e de lesões e alterações pré-cancerígenas relacionados ao trabalho.

Os prontuários médicos dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas devem ser mantidos por período mínimo de 40 (quarenta) anos após o desligamento do empregado.

O médico responsável pelo PCMSO deve orientar os médicos que realizam o exame clínico desses empregados sobre a importância da identificação de lesões e alterações clínicas ou laboratoriais que possam estar relacionadas à exposição ocupacional a substâncias químicas cancerígenas e a radiações ionizantes.

Os exames complementares para os empregados expostos a agentes químicos cancerígenos, conforme informado no PGR da organização, são obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 10% (dez por cento) dos limites de exposição ocupacional, ou quando não houver avaliação ambiental, e devem ser executados e interpretados com base nos critérios constantes na NR 7.

9.3.4- Radiações Ionizantes

Os empregados devem ser avaliados, no exame médico admissional, de retorno ao trabalho ou de mudança de risco, quanto à sua aptidão para exercer atividades em áreas controladas ou supervisionadas, de acordo com as informações do PGR e a classificação da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN (Norma CNEN NN 3.01) para áreas de trabalho com radiação ou material radioativo.

A informação sobre aptidão ou inaptidão para exercer atividade com exposição a radiação ou material radioativo deve ser consignada no ASO do empregado.

No caso de exposição ocupacional acima do limite de dose anual de radiação ionizante, efetiva ou equivalente, deve ser realizada nova avaliação médica do empregado para definição sobre a sua continuidade na atividade, quando deve ser emitido novo ASO.

No caso de exposição ocupacional acidental a níveis elevados de radiação ionizante, deve ser realizada nova avaliação médica, com coleta de hemograma completo imediatamente e 24 horas após a exposição.

Os prontuários médicos dos empregados expostos a radiações ionizantes devem ser mantidos até a data em que o empregado completará 75 anos e, pelo menos, por período mínimo de 30 (trinta) anos após o desligamento do empregado.

Ainda, segundo NR 32 nos seus itens:

32.4.4 Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação.

32.4.5 Toda instalação radiativa deve dispor de monitoração individual e de áreas.

32.4.5.1 Os dosímetros individuais devem ser obtidos, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual acreditados pela CNEN.

32.4.5.2 A monitoração individual externa, de corpo inteiro ou de extremidades, deve ser feita através de dosimetria com periodicidade mensal e levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas.

32.4.5.3 Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de 24 horas.

32.4.5.4 Após ocorrência ou suspeita de exposição acidental a fontes seladas, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética, a critério médico.

32.4.5.5 Após ocorrência ou suspeita de acidentes com fontes não seladas, sujeitas a exposição externa ou com contaminação interna, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética, a análise in vivo e in vitro, a critério médico.

32.4.16 Dos Serviços de Radiodiagnóstico Odontológico.

32.4.16.1 Na radiologia intra-oral:

- a) todos os trabalhadores devem manter-se afastados do cabeçote e do paciente a uma distância mínima de 2 metros;
- b) nenhum trabalhador deve segurar o filme durante a exposição;
- c) caso seja necessária a presença de trabalhador para assistir ao paciente, esse deve utilizar os EPIs.

32.4.16.2 Para os procedimentos com equipamentos de radiografia extra-oral deverão ser seguidos os mesmos requisitos do radiodiagnóstico médico.

9.3.5 - Exames para Trabalho em Altura

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.

A NR 35 discorre a seguir:

"35.4.4 Cabe à organização avaliar o estado de saúde dos empregados que exercem atividades de trabalho em altura de acordo com o estabelecido na NR-07 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), em especial o item 7.5.3, considerando patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, bem como os fatores psicossociais. 35.4.4.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador">

Os exames complementares específicos para trabalho em altura são: ECG (eletrocardiograma), Hemograma Completo, Glicemia de Jejum, Acuidade Visual e Audiometria. Estes exames serão realizados no Exame Admissional e no Exame Periódico. Poderá também ser realizada Avaliação Psicossocial, no Exame Admissional e no Exame Periódico, caso, após o médico examinador realizar a avaliação dos fatores psicossociais, e, assim, indicar.

Observação:

É realizado para triagem de convulsão/ epilepsia :Questionário OMS de investigação de epilepsia **(Anexo 11.1)**.

O médico examinador poderá incluir a qualquer momento, independentemente do tipo do tipo de exame médico ocupacional realizado, algum exame complementar em razão da análise de risco ocupacional por função, assim como solicitar algum exame complementar para esclarecimento diagnóstico de patologia não ocupacional que poderia comprometer o estado de saúde do mesmo. Estes exames não estariam descritos no ASO do colaborador, somente fariam parte da ficha clínica do mesmo, pois tais exames não fazem parte do PCMSO.

Observação:

Em razão de alguns trabalhadores possuírem peso superior à massa padrão utilizada nos ensaios dinâmicos aos equipamentos de proteção contra queda em trabalho em altura (100 kg) é necessário que a empresa observe que seus equipamentos tenham especificações adequadas, comprovadas e dimensionadas para usuários com massa corporal maior do que 100 kg. Reforçamos sobre a importância do dimensionamento, pois diversos cinturões de segurança podem suportar um trabalhador com mais de 100 kg, porém se o sistema não for dimensionado para reduzir o impacto de uma queda, este poderá lesionar o trabalhador mesmo sem bater em nada durante a queda.

9.3.6- Exames para Trabalho em Espaço Confinado

Segundo o item 33.2.2 da Norma Regulamentadora 33, considera-se espaço confinado qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente aos seguintes requisitos:

- a) não ser projetado para ocupação humana contínua;
- b) possuir meios limitados de entrada e saída; e
- c) em que exista ou possa existir atmosfera perigosa.

Os trabalhadores designados para atividades em espaços confinados devem ser avaliados quanto à aptidão física e mental, considerando os fatores de riscos psicossociais. A aptidão para trabalhos em espaços confinados deve estar consignada no Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, nos termos da NR-07 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO).

Os exames complementares específicos para trabalho em espaço confinado são: ECG (eletrocardiograma), Acuidade Visual, Hemograma Completo, Glicemia de Jejum, Espirometria, Rx tórax OIT, Audiometria, Avaliação Psicossocial (obrigatório no Exame Admissional e Exame Periódico). Estes exames serão realizados no Exame Admissional e no Exame Periódico.

Observação:

Durante a consulta ocupacional, o médico realiza a triagem de convulsão/ epilepsia através do preenchimento do Questionário OMS para investigação e rastreamento de epilepsia (**Anexo 11.1**).

O médico examinador poderá incluir a qualquer momento, independentemente do tipo do tipo de exame médico ocupacional realizado, algum exame complementar em razão da análise de risco ocupacional por função, assim como solicitar algum exame complementar para esclarecimento diagnóstico de patologia não ocupacional que poderia comprometer o estado de saúde do mesmo. Estes exames não estariam descritos no ASO do colaborador, somente fariam parte da ficha clínica do mesmo, pois tais exames não fazem parte do PCMSO.

9.3.7 Motoristas e Operadores de Máquinas Pesadas

Os exames complementares específicos para as operações supracitadas são: ECG (eletrocardiograma), Hemograma Completo, Glicemia de Jejum, Acuidade Visual e Audiometria. Estes exames serão realizados no Exame Admissional e no Exame Periódico. Poderá também ser realizada Avaliação Psicossocial, no Exame Admissional e no Exame Periódico, caso, após o médico examinador realizar a avaliação dos fatores psicossociais, e, assim, indicar.

Observação:

É realizado para triagem de convulsão/ epilepsia :Questionário OMS de investigação de epilepsia (**Anexo 11.1**).

O médico examinador poderá incluir a qualquer momento, independentemente do tipo do tipo de exame médico ocupacional realizado, algum exame complementar em razão da análise de risco ocupacional por função, assim como solicitar algum exame complementar para esclarecimento diagnóstico de patologia não ocupacional que poderia comprometer o estado de saúde do mesmo. Estes exames não estariam descritos no ASO do colaborador, somente fariam parte da ficha clínica do mesmo, pois tais exames não fazem parte do PCMSO.

9.3.8 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde (NR 32)

Esta Norma Regulamentadora - NR 32- tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

O PCMSO, além do previsto na NR-07, e observando o disposto no inciso I do item 32.2.2.1, deve contemplar:

- a) o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos;
- b) a localização das áreas de risco segundo os parâmetros do item 32.2.2;
- c) a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que estão expostos;
- d) a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos;
- e) o programa de vacinação.

32.2.3.2 Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho, que implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao médico coordenador ou responsável pelo PCMSO.

32.2.3.3 Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar do PCMSO:

- a) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças;
- b) as medidas para descontaminação do local de trabalho;
- c) o tratamento médico de emergência para os trabalhadores;
- d) a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes;
- e) a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores;
- f) as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores;
- g) a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde depositários de imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais.

32.2.3.5 Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.

32.2.4.3.2 O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.

32.10.15 Todos os lavatórios e pias devem:

- a) possuir torneiras ou comandos que dispensem o contato das mãos quando do fechamento da água;
- b) ser providos de sabão líquido e toalhas descartáveis para secagem das mãos.

32.2.4.4 Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.

32.2.4.5 O empregador deve vedar:

- a) a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos;
- b) o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho;
- c) o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho;
- d) a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim;
- e) o uso de calçados abertos.

32.2.4.9 O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada:

- a) sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos;
- b) durante a jornada de trabalho;
- c) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos.

32.2.4.9.1 A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos e deve incluir:

- a) os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde;
- b) medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes;
- c) normas e procedimentos de higiene;
- d) utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho;
- e) medidas para a prevenção de acidentes e incidentes;
- f) medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de incidentes e acidentes.

32.2.4.9.2 O empregador deve comprovar para a inspeção do trabalho a realização da capacitação através de documentos que informem a data, o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos.

32.2.4.10 Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho.

32.2.4.10.1 As instruções devem ser entregues ao trabalhador, mediante recibo, devendo este ficar à disposição da inspeção do trabalho.

32.2.4.11 Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho e à CIPA.

32.2.4.13 Os colchões, colchonetes e demais almofadados devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo desinfecção e fácil higienização.

32.2.4.13.1 O revestimento não pode apresentar furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias.

32.2.4.14 Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.

32.2.4.15 São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.

32.2.4.17 Da Vacinação dos Trabalhadores

32.2.4.17.1 A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.

32.2.4.17.2 Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.

32.2.4.17.3 O empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço.

32.2.4.17.4 A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde.

32.2.4.17.5 O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, devendo, nestes casos, guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho.

32.2.4.17.6 A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto na NR-07.

32.5 Dos Resíduos

32.5.1 Cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de forma continuada, os trabalhadores nos seguintes assuntos:

- a) segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos;
- b) definições, classificação e potencial de risco dos resíduos;
- c) sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;
- d) formas de reduzir a geração de resíduos;
- e) conhecimento das responsabilidades e de tarefas;
- f) reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos;
- g) conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;
- h) orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs.

32.5.2 Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem atender ao disposto na NBR 9191 e ainda ser:

- a) preenchidos até 2/3 de sua capacidade;
- b) fechados de tal forma que não se permita o seu derramamento, mesmo que virados com a abertura para baixo;
- c) retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e fechamento;
- d) mantidos íntegros até o tratamento ou a disposição final do resíduo.

32.5.3 A segregação dos resíduos deve ser realizada no local onde são gerados, devendo ser observado que:

- a) sejam utilizados recipientes que atendam as normas da ABNT, em número suficiente para o armazenamento;
- b) os recipientes estejam localizados próximos da fonte geradora;
- c) os recipientes sejam constituídos de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e que sejam resistentes ao tombamento;
- d) os recipientes sejam identificados e sinalizados segundo as normas da ABNT.

32.5.3.2 Para os recipientes destinados a coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal.

32.5.3.2.1 O recipiente para acondicionamento dos perfurocortantes deve ser mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte.

32.5.4 O transporte manual do recipiente de segregação deve ser realizado de forma que não exista o contato do mesmo com outras partes do corpo, sendo vedado o arrasto.

32.5.5 Sempre que o transporte do recipiente de segregação possa comprometer a segurança e a saúde do trabalhador, devem ser utilizados meios técnicos apropriados, de modo a preservar a sua saúde e integridade física.

32.5.6 A sala de armazenamento temporário dos recipientes de transporte deve atender, no mínimo, às seguintes características:

- a) pisos e paredes laváveis;
- b) ralo sifonado;
- c) ponto de água;
- d) pontos de luz;
- e) ventilação adequada;
- f) abertura dimensionada de forma a permitir a entrada dos recipientes de transporte.

- I. ser dotada de:
- II. ser mantida limpa e com controle de vetores;
- III. conter somente os recipientes de coleta, armazenamento ou transporte;
- IV. ser utilizada apenas para os fins a que se destina;
- V. estar devidamente sinalizada e identificada.

32.5.7 O transporte dos resíduos para a área de armazenamento externo deve atender aos seguintes requisitos:

- a) ser feito através de carros constituídos de material rígido, lavável, impermeável, provido de tampo articulado ao próprio corpo do equipamento e cantos arredondados;
- b) ser realizado em sentido único com roteiro definido em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas.

32.5.7.1 Os recipientes de transporte com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo.

32.5.8 Em todos os serviços de saúde deve existir local apropriado para o armazenamento externo dos resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa.

32.5.8.1 O local, além de atender às características descritas no item 32.5.6, deve ser dimensionado de forma a permitir a separação dos recipientes conforme o tipo de resíduo.

32.5.9 Os rejeitos radioativos devem ser tratados conforme disposto na Resolução CNEN NE6.05.

32.8 Da Limpeza e Conservação

32.8.1 Os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e de forma continuada, quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de emergência.

32.8.1.1 A comprovação da capacitação deve ser mantida no local de trabalho, à disposição da inspeção do trabalho.

9.3.8.1- Saúde do Trabalhador

- Os colaboradores deverão receber treinamento específico sobre a forma adequada de manuseio do resíduo infectante, biológico ou químico, assim como serem treinados quanto aos temas relacionados ao uso adequado de EPI e Acidentes com materiais biológicos e com materiais perfurocortantes.

- A utilização de EPI é obrigatória quando manipular os resíduos.

- Os colaboradores deverão realizar os exames de saúde ocupacionais periodicamente e os exames complementares, de acordo a NR-7.

- Todos os colaboradores deverão ser vacinados contra Tétano, Difteria e Hepatite B, conforme NR-32, assim como cumprir com as orientações do Ministério da Saúde, as quais também incluem a vacinação contra Sarampo, Rubéola e Caxumba (Tríplice Viral), Febre Amarela, Influenza (Gripe) e Covid - 19.

9.3.8.2- Cuidados com o Uso e Acondicionamento de Materiais Perfurocortantes

Recomendações específicas devem ser seguidas durante a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de material perfurocortante:

- Máxima atenção durante a realização dos procedimentos;
- Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfurocortantes;
- As agulhas não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos (utilizar por exemplo um alveolômetro ou pinça porta agulha);
- Todo material perfurocortante (agulhas, lâmina de bisturi, vidrarias, entre outros), mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipientes próprios para sua disposição;
- Seguir as recomendações para montagem e preenchimento das caixas de perfurocortantes;
- Os recipientes de acondicionamento dos RSS do Grupo E - perfurocortante devem ser substituídos de acordo com a demanda ou quando o nível de preenchimento atingir 3/4 (três quartos) da capacidade ou de acordo com as instruções do fabricante, sendo proibidos seu esvaziamento manual e seu reaproveitamento.

9.3.8.3 -Conduas a Serem Observadas em Caso de Acidentes de Trabalho com Materiais Biológicos

Os acidentes envolvendo sangue ou outros fluidos orgânicos potencialmente contaminados correspondem às exposições mais comumente relatadas.

Os ferimentos com material perfurocortantes em geral são considerados extremamente perigosos por serem potencialmente capazes de transmitir mais de 20 tipos de patógenos diferentes. Sendo que, os agentes infecciosos mais frequentemente relatados são o vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e os vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV).

O risco de adquirir infecção pós-exposição ocupacional é variável e depende de diversos fatores como o tipo de acidente, tamanho e gravidade da lesão, presença e volume de sangue envolvido, condições clínicas do paciente-fonte e seguimento adequado pós-exposição.

As situações de exposição ao HIV constituem em atendimento de urgência, tendo como limite máximo para início da profilaxia com antirretrovirais (ARV) 72 horas após a exposição de risco e atendimento o mais precoce possível para a exposição ao vírus da hepatite B e hepatite C.

Existem tipos de exposição envolvendo material biológico que são consideradas de risco;

- Exposições percutâneas: lesões provocadas por instrumentos perfurantes ou cortantes (ex.: agulhas, lâminas de bisturi, ampolas de vidros, etc.).
- Exposições de mucosas: ocorrência de respingos na face envolvendo olho, nariz ou boca.
- Exposição de pele não íntegra: contato com locais onde a pele apresenta dermatites ou feridas abertas.
- Arranhaduras e/ou mordeduras: são consideradas de risco quando envolvem a presença de sangue.

Os procedimentos referentes aos acidentes de trabalho com materiais biológicos são:

1. Comunicar imediatamente ao setor de Segurança do trabalho da empresa.
2. Utilizar medidas iniciais no local de trabalho ou do acidente, sobretudo no cuidado do local do ferimento ou área corporal acometida:
 - Exposições percutâneas: o local exposto deve ser lavado exaustivamente com água e sabão. Não apertar, espremer ou pressionar o local, pois isto pode aumentar a superfície de contato. Nunca utilizar agentes irritantes (como hipoclorito, éter, benzina, glutaraldeído) sobre o local.
 - Exposição de mucosa (olhos, boca e nariz): a área exposta deve ser lavada apenas com água ou soro fisiológico 0,9%.
3. Encaminhar o acidentado e o paciente/fonte (com prévia autorização/consentimento de ambos) para os centros médicos de referência, onde deverá ser colhido o sangue para teste rápido de HIV e sorologias de HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total, anti-HCV e avaliada a indicação da profilaxia medicamentosa para os mesmos (padronizada pela Coordenação Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde). O acompanhamento clínico-laboratorial segundo condições e sorologias do paciente fonte, quando necessário, ficará a cargo dos profissionais de saúde do centro médico onde foram acolhidos o paciente acidentado e o paciente fonte. O acompanhamento do colaborador acidentado será realizado pelo CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador).
- 4 O Serviço de Segurança do Trabalho deverá iniciar o processo de encaminhamento dos documentos administrativos e previdenciários referentes ao caso, dentro do prazo legal estabelecido, fazendo o preenchimento da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e notificar ao SINAM (Sistema Nacional de Atendimento Médico).
5. O Serviço de Segurança do Trabalho procederá com as medidas de investigação e avaliação do acidente, envolvendo o acidentado, seu coordenador/líder, buscando reduzir os riscos e prevenir futuros acidentes com materiais biológicos.
6. O colaborador (a) acidentado (a) deverá manter acompanhamento com o CEREST até a alta médica.

9.3.8.4. Unidades de Referência em Caso de Acidente de Trabalho com Materiais Biológicos

- **CAIS** Bairro Goiá
- **CAIS** Campinas
- **CAIS** Deputado João Natal (CAIS Vila Nova)
- **UPA** Chácara do Governador
- **UPA** Jardim Novo Mundo
- **UPA** João Batista de Sousa Júnior (UPA Itaipu)

- **UPA** Maria Pires Perillo (UPA Noroeste)

9.3.8.5. Fluxograma para Acidente de Trabalho com Materiais Biológicos

Fluxograma para acidente de trabalho com materiais biológicos (**Anexo 11.5**)

9.4 Exame Audiométrico

O Anexo II - Controle Médico Ocupacional da Exposição a Níveis de Pressão Sonora Elevados da NR-7 estabelece diretrizes para avaliação e controle médico ocupacional da audição de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados.

Segue detalhamento do referido anexo:

"2. Devem ser submetidos a exames audiométricos de referência e sequenciais todos os empregados que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora estejam acima dos níveis de ação, conforme informado no PGR da organização, independentemente do uso de protetor auditivo.

2.1 Compõem os exames audiológicos de referência e sequenciais:

- a) anamnese clínico-ocupacional;*
- b) exame otológico;*
- c) exame audiométrico realizado segundo os termos previstos neste Anexo;*
- d) outros exames audiológicos complementares solicitados a critério médico.*

3. Exame audiométrico

3.1 O exame audiométrico será realizado em cabina audiométrica, cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os níveis máximos permitidos, de acordo com a norma técnica ISO 8253-1.

3.1.1 Nas empresas em que existir ambiente acusticamente tratado, que atenda à norma técnica ISO 8253-1, a cabina audiométrica poderá ser dispensada.

3.2 O audiômetro deve ser submetido a procedimentos de verificação e controle periódico do seu funcionamento, incluindo:

- I - Aferição acústica anual;*
- II - Calibração acústica;*

- a) sempre que a aferição acústica indicar alteração;*
- b) quando houver recomendação de prazo pelo fabricante;*
- c) a cada 5 (cinco) anos, se não houver indicação do fabricante.*

III - aferição biológica precedendo a realização dos exames audiométricos

3.2.1 Os procedimentos constantes das alíneas "a" e "b" acima devem seguir o preconizado na norma técnica ISO 8253-1, e os resultados devem ser incluídos em certificado de aferição e/ou calibração que acompanhará o equipamento.

3.2.1.1 Na impossibilidade da realização do exame audiométrico nas condições previstas no item 3.1, o responsável pela execução do exame avaliará a viabilidade de sua realização em ambiente silencioso, por meio do exame audiométrico em 2 (dois) indivíduos, cujos limiares auditivos sejam conhecidos, detectados em exames audiométricos de referência atuais, e que não haja diferença de limiar auditivo, em qualquer frequência e em qualquer um dos 2 (dois) indivíduos examinados, acima de 5 (cinco) dB (NA) (nível de audição em decibéis). Ienos constantes das alíneas ma devem seguir o preconizado na norma técnica ISO 8253-1, e os resultados devem ser incluídos em certificado de aferição e/ou calibração que acompanhará o equipamento.

3.3 O exame audiométrico deve ser executado por médico ou fonoaudiólogo, conforme resoluções dos respectivos conselhos federais profissionais.

3.4 O empregado deve permanecer em repouso auditivo por um período mínimo de 14 horas até o exame audiométrico.

3.5 O resultado do exame audiométrico deve ser registrado e conter, no mínimo:

- a) nome, idade, CPF e função do empregado;
- b) razão social da organização e CNPJ ou CPF;
- c) tempo de repouso auditivo cumprido para a realização do exame audiométrico;
- d) nome do fabricante, modelo e data da última aferição acústica do audiômetro;
- e) traçado audiométrico e símbolos, conforme indicados neste Anexo;
- f) nome, número de registro no conselho regional e assinatura do profissional responsável pelo exame audiométrico.

3.6 O exame audiométrico deve ser realizado, sempre, pela via aérea nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz.

3.6.1 No caso de alteração detectada no teste pela via aérea, a audiometria deve ser feita, também, por via óssea, nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz, ou ainda segundo a avaliação do profissional responsável pela execução do exame.

3.6.2 Segundo a avaliação do profissional responsável, no momento da execução do exame, podem ser determinados os Limiares de Reconhecimento de Fala - LRF.

4. Periodicidade dos exames audiométricos

4.1 O exame audiométrico deve ser realizado, no mínimo:

- a) na admissão;
- b) anualmente, tendo como referência o exame da alínea "a" acima;
- c) na demissão.

4.1.1 Na demissão pode ser aceito exame audiométrico realizado até 120 (cento e vinte) dias antes da data de finalização do contrato de trabalho.

4.2 O intervalo entre os exames audiométricos pode ser reduzido a critério do médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

4.3 O empregado deve ser submetido a exame audiométrico de referência e a exames audiométricos sequenciais na forma descrita nos subitens seguintes.

4.3.1 Exame audiométrico de referência é aquele com o qual os exames sequenciais serão comparados e que deve ser realizado:

- a) quando não houver um exame audiométrico de referência prévio;
- b) quando algum exame audiométrico sequencial apresentar alteração significativa em relação ao exame de referência.

4.3.2 Exame audiométrico sequencial é aquele que será comparado com o exame de referência e se aplica a todo empregado que já possua um exame audiométrico de referência prévio.

5.5 Para fins deste Anexo, o exame audiométrico de referência deve permanecer como tal até que algum dos exames audiométricos sequenciais demonstre desencadeamento ou agravamento de PAINPSE.

7. Devem ser motivo de especial atenção empregados expostos a substâncias ototóxicas e/ou vibração, de forma isolada ou simultânea à exposição a ruído potencialmente nocivo à audição.

9.5 - EXAME RADIOLÓGICO

Quanto aos Exames Radiológicos, Anexo III da NR-7, contempla o seguinte:

QUADRO 1 - Periodicidade dos Exames Radiológicos para Empregados Expostos a Sílica e Asbesto

Empresas com medições quantitativas periódicas	Radiografia de tórax
LSC* ≤ 10% LEO**	na admissão; e na demissão, se o último exame foi realizado há mais de 2 anos.
LSC > 10% e ≤ 50% LEO	na admissão; a cada 5 anos até os 15 anos de exposição, e, após, a cada 3 anos; e na demissão, se o último exame foi realizado há mais de 2 anos.
LSC > 50% e ≤ 100% LEO	na admissão; a cada 3 anos até 15 anos de exposição, e, após, a cada 2 anos; e na demissão, se o último exame foi realizado há mais de 1 ano.
LSC > 100% LEO	na admissão; a cada ano de exposição; na demissão, se o último exames foi realizado há mais de 1 ano.
Empresas sem avaliações quantitativas	na admissão; a cada 2 anos até 15 anos de exposição, e, após, a cada ano ; e na demissão, se o último exame foi realizado há mais de 1 ano.

*LSC = Limite superior do intervalo de confiança da média aritmética estimada para uma distribuição lognormal com confiança estatística de 95%.

**LEO = Limite de exposição ocupacional.

NOTA 1: trabalhadores que apresentarem leitura Radiológica 0/1 ou mais deverão ser avaliados por profissionais médicos especializados.

NOTA 2: Para trabalhadores que tenha a sua exposição diminuída, mas que estiveram expostos a concentrações superiores por um ano ou mais, deverá ser mantido o mesmo intervalo de exames radiológicos do período de maior exposição.

QUADRO 2 - Periodicidade dos Exames Radiológicos para Empregados Expostos a poeiras Contendo Partículas Insolúveis ou Pouco Solúveis de Baixa Toxicidade e não Classificadas de Outra Forma***

Empresas com medições quantitativas periódicas de poeira respirável	Radiografia de tórax
LSC* £ 10% LEO**	na admissão.
LSC > 10% e £ 100% LEO	na admissão; após 5 anos de exposição; e e repetir a critério clínico.
LSC > 100% LEO	na admissão; e repetir a critério clínico.
Empresas sem avaliações quantitativas	na admissão; e a cada 5 anos.

*LSC = Limite superior do intervalo de confiança da média aritmética estimada para uma distribuição lognormal com confiança estatística de 95%

**LEO = Limite de exposição ocupacional

**Para ser classificado como PNOS (particles not otherwise specified), o material particulado sólido deve ter as seguintes características (ACGIH, 2017):

- a) não possuir um LEO definido;
- b) ser insolúvel ou pouco solúvel na água (ou preferencialmente no fluído pulmonar, se esta informação estiver disponível);
- c) ter baixa toxicidade, isto é, não ser citotóxico, genotóxico ou quimicamente reativo com o tecido pulmonar, não se emitir radiação ionizante, não ser sensibilizante, não causar defeitos tóxicos além da inflamação ou mecanismo de sobrecarga.

Radiografias de Tórax para apoio ao diagnóstico de Pneumoconioses (NR-07):

"2.1 Os procedimentos para realização de RXTP devem atender às diretrizes da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.º 330, de 20 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o uso dos raios X diagnósticos em todo o território nacional, ou suas revisões mais recentes.

2.2 Os equipamentos utilizados para realização de RXTP devem possuir as seguintes características:

- a) gerador monofásico de alta frequência de preferência e/ou trifásico de 6 a 12 pulsos, no mínimo de 500 mA;
- b) tubo de raios X - 30/50;
- c) filtro de alumínio de 3 a 5 mm;
- d) grade fixa com distância focal de 1,50 m;
- e) razão da grade 10:1 com mais de 100 colunas;
- f) razão da grade 12:1 com 100 colunas.

2.2.1 A unidades móveis de raios X podem utilizar equipamentos de 300 mA (trezentos miliamperes) desde que o gerador tenha potência mínima de 30 kW (trinta quilowatts).

2.2.2 No caso de utilização de equipamentos para RXTP em unidades móveis, devem ser cumpridas, além do exigido acima, as seguintes condições:

- a) *dispor de alvará específico para funcionamento da unidade transportável de raios X;*
- b) *ser realizado por profissional legalmente habilitado e sob a supervisão de responsável técnico nos termos da RDC já referida;*
- c) *dispor de Laudo Técnico emitido por profissional legalmente habilitado, comprovando que os equipamentos utilizados atendem ao exigido neste Anexo.*

2.3 A técnica radiológica para RXTP deve observar os seguintes padrões:

- a) *foco fino (0,6 a 1,2 mm);*
- b) *100 mA ou 200 mA (tubo de alta rotação);*
- c) *tempo - 0,01 a 0,02 ou 0,03 segundos;*
- d) *constante - 40 ou 50 kV (quilovolts).*

2.4 O processamento dos filmes deve ser realizado por processadora automática e que atenda às exigências dos órgãos ambientais responsáveis.

2.5 A identificação dos filmes radiográficos utilizados em radiologia convencional deve incluir, no canto superior direito do filme radiográfico, a data da realização do exame, o número de ordem do serviço ou do prontuário do empregado e nome completo do empregado ou as iniciais do nome completo.

2.6 A leitura radiológica deve ser descritiva e, para a interpretação e emissão dos laudos dos RXTP, devem ser utilizados, obrigatoriamente, os critérios da OIT na sua revisão mais recente e a coleção de radiografias-padrão da OIT.

2.6.1 Em casos selecionados, a critério clínico, pode ser realizada a Tomografia Computadorizada de Alta Resolução de Tórax.

2.6.2 As leituras radiológicas devem ser anotadas em Folha de Leitura Radiológica que contenha a identificação da radiografia e do leitor, informações sobre a qualidade da imagem e os itens da classificação.

2.7 O laudo do exame radiológico deve ser assinado por um ou mais de um, em caso de múltiplas leituras, dos seguintes profissionais:

- a) *médico radiologista com título de especialista ou registro de especialidade no Conselho Regional de Medicina e com qualificação e/ou certificação em Leitura Radiológica das Pneumoconioses - Classificação Radiológica da OIT, por meio de curso/módulo específico;*
- b) *médicos de outras especialidades, que possuam título ou registro de especialidade no Conselho Regional de Medicina em Pneumologia, Medicina do Trabalho ou Clínica Médica (ou uma das suas subespecialidades) e que possuam qualificação e/ou certificação em Leitura Radiológica das Pneumoconioses - Classificação Radiológica da OIT, por meio de curso/módulo específico.*

2.8 As certificações são concedidas por aprovação nos exames do National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH ou pelo exame "AIR-Pneumo", sendo que, em caso de certificação concedida pelo exame do NIOSH, o profissional também pode ser denominado "Leitor B".

2.9 Sistemas de radiologia digital do tipo CR ou DR podem ser utilizados para a obtenção de imagens radiológicas do tórax para fins de interpretação radiológica da OIT.

2.9.1 Os parâmetros físicos para obtenção de RXTP de qualidade técnica adequada, utilizando-se equipamentos de radiologia digital, devem ser similares aos da radiologia convencional.

2.9.2 A identificação dos filmes digitais deve conter, no mínimo, a data da realização do exame, número de ordem do serviço ou do prontuário do paciente e nome completo do paciente ou as iniciais do nome completo.

2.10 A Interpretação Radiológica de radiografias digitais deve seguir os critérios da OIT.

2.10.1 *Imagens geradas em sistemas de radiologia digital (CR ou DR) e transferidas para monitores só podem ser interpretadas com as radiografias-padrão em monitor anexo.*

2.10.2 *Os monitores utilizados para exibição da radiografia a ser interpretada e das radiografias-padrão devem ser de qualidade diagnóstica, possuir resolução mínima de 3 megapixels e 21" (54 cm) de exibição diagonal por imagem.*

2.10.3 *Imagens digitais impressas em filmes radiológicos devem ser interpretadas com as radiografias-padrão em formato impresso, em negatoscópios.*

2.10.4 *Não é permitida a interpretação de radiografias digitais, para fins de classificação radiológica da OIT, nas seguintes condições:*

- a) radiografias em monitores comparadas com as radiografias-padrão em negatoscópio, ou o inverso;*
- b) radiografias digitais impressas em filmes radiológicos com reduções menores do que 2/3 do tamanho original;*
- c) radiografias digitais impressas em papel fotográfico;*
- d) imagens originadas no sistema de radiografia convencional que foram digitalizadas por scanner e, posteriormente, impressas ou exibidas em tela.*

2.11 *Os serviços que ofertem radiologia digital devem assegurar a confidencialidade dos arquivos eletrônicos e de dados dos trabalhadores submetidos a RXTP admissionais, periódicos e demissionais, para fins da classificação radiológica da OIT, por meio de procedimentos técnicos e administrativos adequados.*

2.12 *RXTP obtidas pelo método convencional devem ser guardadas em filmes radiológicos, em formato original.*

2.13 *Imagens obtidas por sistemas digitais (CR ou DR) devem ser armazenadas nos seguintes formatos:*

- a) impressas em filmes radiológicos cuja redução máxima seja equivalente a 2/3 do tamanho original; ou*
- b) em mídia digital, gravadas em formato DICOM e acompanhadas de visualizador (viewer) de imagens radiológicas".*

9.6 - EXAME ESPIROMÉTRICO

Quanto à Espirometria, o Anexo III da NR-7, abrange o seguinte:

2.1 Os empregados expostos ocupacionalmente a poeiras minerais indicadas no inventário de riscos do PGR devem ser submetidos a espirometria nos exames médicos admissional e a cada dois anos.

2.2 Os empregados expostos ocupacionalmente a outros agentes agressores pulmonares indicados no inventário de riscos do PGR, que não as poeiras minerais, deverão ser submetidos a espirometria se desenvolverem sinais ou sintomas respiratórios.*

2.3 Nas funções com indicação de uso de equipamentos individuais de proteção respiratória, os empregados com histórico de doença respiratória crônica ou sinais e sintomas respiratórios devem ser submetidos a espirometria no exame médico admissional ou no exame de mudança de risco.

2.4 No caso da constatação de alteração espirométrica, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve:

- a) investigar possíveis relações do resultado com as exposições ocupacionais; e*
- b) avaliar a necessidade de encaminhamento para avaliação médica especializada.*

3.5 Nos exames pós-demissionais em empregados expostos ao asbesto, a periodicidade da espirometria deve ser a mesma do exame radiológico.

3.6 A organização deve garantir que a execução e a interpretação das espirometrias sigam as padronizações constantes nas Diretrizes do Consenso Brasileiro sobre Espirometria na sua mais recente versão.

3.7 A interpretação do exame e o laudo da espirometria devem ser feitos por médico.

**"Outros agentes agressores pulmonares" referem-se a agentes químicos que possam ser inalados na forma de partículas, fumos, névoas ou vapores e que sejam considerados como sensibilizantes e/ou irritantes pelos critérios constantes no Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos - GHS. "(NR)".*

9.7 - GESTANTES/ LACTANTES

Ante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.938 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto aos entendimentos envolvendo gestantes e lactantes, e da necessidade legal de conhecer a salubridade do ambiente laboral que estas colaboradoras atuam, para melhor caracterização da aptidão ao trabalho, solicitamos que a Empresa, ao tomar conhecimento da gestação ou da suspeita, como também, da lactação (amamentação) envie suas colaboradoras para avaliação ocupacional, juntamente, com LTCAT do cargo/função da colaboradora.

9.8 - MANIPULADORES DE ALIMENTO

A periodicidade da realização de exames médicos será anual, sendo determinado a realização dos seguintes exames: hemograma, micológico de unhas, exame de urina (EAS), coprocultura e coproparasitológico.

Recomenda-se enfatizar cuidados de higiene como: banhos diários; unhas curtas, limpas e sem esmaltes - sem adornos, inclusive alianças; barbas aparadas. Além de cuidados comportamentais: não colocar dedo no nariz e ouvido; não espirrar, tossir e conversar sob os alimentos; não enxugar suor com as mãos e braços (usar toalha descartável); não experimentar alimentos com as mãos ou com a colher que está preparando os alimentos.

O colaborador deverá ser afastado e não manipular alimentos quando apresentar sinais e sintomas sugestivos de processos infecciosos, tais como infecções gastrointestinais agudas ou crônicas (diarreias ou disenteria), do trato respiratório (infecções pulmonares ou faringites) e cutâneas como feridas, lesões, chagas ou cortes nas mãos e braços, bem como vômitos, febre e infecções oculares.

9.9 - EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO CALOR E ACLIMATIZAÇÃO

Segundo o Anexo III da NR 09 - Calor, seguem Responsabilidades da organização:

- A organização deve adotar medidas de prevenção, de modo que a exposição ocupacional ao calor não cause efeitos adversos à saúde do trabalhador.
- A organização deve orientar os trabalhadores especialmente quanto aos seguintes aspectos:
 - a) fatores que influenciam os riscos relacionados à exposição ao calor;
 - b) distúrbios relacionados ao calor, com exemplos de seus sinais e sintomas, tratamentos, entre outros;
 - c) necessidade de informar ao superior hierárquico ou ao médico a ocorrência de sinais e sintomas relacionados ao calor;
 - d) medidas de prevenção relacionadas à exposição ao calor, de acordo com a avaliação de risco da atividade;
 - e) informações sobre o ambiente de trabalho e suas características;
 - f) situações de emergência decorrentes da exposição ocupacional ao calor e condutas a serem adotadas.

A respeito das Medidas Corretivas, seguem orientações, segundo norma:

- As medidas corretivas visam reduzir a exposição ocupacional ao calor a valores abaixo do limite de exposição.
- Quando ultrapassados os limites de exposição estabelecidos no Quadro 2, devem ser adotadas pela organização uma ou mais das seguintes medidas corretivas:
 - a) adequar os processos, as rotinas ou as operações de trabalho;
 - b) alternar operações que gerem exposições a níveis mais elevados de calor com outras que não apresentem exposições ou impliquem exposições a menores níveis, resultando na redução da exposição; e
 - c) disponibilizar acesso a locais, inclusive naturais, termicamente mais amenos, que possibilitem pausas espontâneas, permitindo a recuperação térmica nas atividades realizadas em locais abertos e distantes de quaisquer edificações ou estruturas naturais ou artificiais.

Conforme o item 4.2.3 da NR 9, o PCMSO deve prever procedimentos e avaliações médicas considerando a necessidade de exames complementares e monitoramento fisiológico quando ultrapassados os limites de exposição previstos no Quadro 2 deste anexo e caracterizado risco de sobrecarga térmica e fisiológica dos trabalhadores expostos ao calor.

Fica caracterizado o risco de sobrecarga térmica e fisiológica com possibilidade de lesão grave a integridade física ou a saúde dos trabalhadores:

- a) quando não forem adotadas as medidas previstas no item 4 do Anexo da NR-09; ou
- b) quando as medidas adotadas não forem suficientes para a redução do risco.

Quanto à Aclimatização, descreve-se na NR-09:

- Para atividades de exposição ocupacional ao calor acima do nível de ação, deve ser considerada a aclimatização dos trabalhadores descrita no PCMSO.
- Quando houver a necessidade de elaboração de plano de aclimatização dos trabalhadores, devem ser considerados os parâmetros previstos na NHO 06 da Fundacentro ou outras referências técnicas emitidas por organização competente.

Orienta-se o Monitoramento da Sobrecarga Fisiológica como prática segura nos trabalhadores expostos ao calor. Segundo a ACGIH, seguem orientações:

A sobrecarga fisiológica excessiva ocorre quando há uma ou mais das seguintes situações*:

- a frequência cardíaca se mantém acima de (180 bpm - idade) por vários minutos;
- a temperatura do núcleo do corpo $>38,5^{\circ}\text{C}$ (pessoas aclimatadas e selecionadas clinicamente); ou $> 38^{\circ}\text{C}$ (não aclimatados e não selecionados);
- a recuperação da FC, após um minuto do pico do esforço de trabalho é maior que 120 bpm;
- ocorre sintomas de fadiga severa e repentina, náusea, vertigens ou tonturas.

*Quando ocorre uma ou mais das situações citadas a exposição individual à sobrecarga térmica deve ser descontinuada.

Assim, orienta-se o monitoramento da sobrecarga fisiológica como prática segura nos trabalhadores expostos ao calor (ACGIH). Porém, nenhum sintoma ou queixa deve ser desprezado.

Sobrecarga Fisiológica Aguda:

- Câimbras- desequilíbrio eletrolítico (reposição de eletrólitos e água);
- Desorientação;
- Resposta de Emergência: exaustão pelo calor: tontura, desmaio e colapso;
- Sudorese intensa mantida por horas; ou
- Perda de peso durante a jornada acima de 1,5% do peso do corpo;
- Excreção de sódio urinário em 24 horas menor que 50 mmoles;
- Insolação: T maior que 40°C .

Sobrecarga Fisiológica Crônica:

- Hipertensão arterial;
- Distúrbios cardiovasculares;
- Distúrbios psíquicos;
- Doenças de pele;
- Acidentes.

Prevenção:

- - Monitorar a sobrecarga térmica;
- - Hidratação: 1 copo de água fresca a cada 20 minutos;
- - Treinamento;
- - Supervisão;
- - Não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas.

PLANO DE ACLIMATAÇÃO/ NIOSH**RECOMENDAÇÕES DE ACLIMATAÇÃO
PARA NOVOS TRABALHADORES**

1º DIA	20 % de duração normal de trabalho
2º DIA	40 % de duração normal de trabalho
3º DIA	60 % de duração normal de trabalho
4º DIA	80 % de duração normal de trabalho
5º DIA	100 % de duração normal de trabalho

**RECOMENDAÇÕES DE ACLIMATAÇÃO PARA TRABALHADORES COM
EXPERIÊNCIA ANTERIOR COM O MESMO TRABALHO (trabalhadores
retornando de uma ausência)**

1º DIA	50 % de duração normal de trabalho
2º DIA	60 % de duração normal de trabalho
3º DIA	80 % de duração normal de trabalho
4º DIA	100 % de duração normal de trabalho

Observação:

- Ajustes nos cronogramas de aclimatização poderão ser necessários em ambos quadros, dependendo da situação do local de trabalho e fatores individuais;
- No retorno ao trabalho com calor, a maioria dos trabalhadores devem ser capazes de suportar, com segurança, uma carga de trabalho após 4 dias de aumento gradual, embora estejam aclimatizados em apenas 2 semanas.

Apresenta-se a seguir os calendários supracitados em forma detalhada:

Aumentar gradualmente o tempo de permanência dos trabalhadores em condições de calor ao longo de sete a 14 dias.

Para os novos trabalhadores, o calendário deve ser:

- Não mais de 20 % da duração habitual do trabalho em condições de exposição ao calor no primeiro dia; e o aumento não superior a 20 % por cada dia adicional.

Para os trabalhadores com experiência anterior, o calendário deve ser:

- não mais de 50 % da duração habitual do trabalho em condições de exposição ao calor no primeiro dia;
- não mais de 60 % da duração habitual do trabalho em condições de exposição ao calor no segundo dia;

- não mais de 80 % da duração habitual do trabalho em condições de exposição ao calor no terceiro dia; e
- não mais do que 100 % da duração habitual do trabalho em condições de exposição ao calor no quarto dia.

Alguns medicamentos podem interferir com a aclimatação. Por exemplo, a medicação hipotensiva (medicamentos que causam baixa tensão arterial), diurética, antiespasmódica, sedativa, tranquilizante, antidepressiva e anfetaminas podem reduzir a capacidade do organismo para lidar com o calor. Os trabalhadores devem procurar aconselhamento médico sobre a adequação de um medicamento, caso trabalhem em ambientes quentes. O consumo de álcool também interfere com a aclimatação.

Supervisionar de perto os novos trabalhadores durante os primeiros 14 dias ou até estarem totalmente aclimatados.

Os trabalhadores que não estão fisicamente aptos precisam de mais tempo para se aclimatarem completamente.

A aclimatação pode ser mantida durante alguns dias em que não há exposição ao calor.

O corpo adapta-se a um novo ambiente térmico através de um processo chamado aclimatação.

A aclimatação é a adaptação fisiológica que ocorre durante a exposição repetida a um ambiente quente, o que inclui:

- aumento da eficiência da transpiração (início mais precoce do processo de transpiração, maior produção de suor e redução da perda de eletrólitos no suor);
- estabilização da circulação;
- a capacidade de realizar um trabalho com baixa temperatura corporal interna e frequência cardíaca;
- aumento do fluxo sanguíneo da pele a uma determinada temperatura corporal interna.

A perda de aclimatação ocorre gradualmente quando uma pessoa é afastada permanentemente de um ambiente quente. No entanto, uma diminuição da tolerância ao calor ocorre mesmo após um longo fim de semana, pelo que muitas vezes não é aconselhável que alguém trabalhe em condições muito quentes no primeiro dia do seu regresso ao trabalho.

Os empregadores devem assegurar que os trabalhadores são aclimatados antes de trabalharem em ambiente quente.

Os novos trabalhadores devem aclimatar-se antes de assumirem uma carga de trabalho completa.

Embora os trabalhadores devidamente formados e fisicamente aptos tolerem melhor o calor do que as pessoas em precário estado físico, a aptidão e a formação não substituem a aclimatação.

Além disso, o nível de aclimatação que cada trabalhador atinge é relativo ao nível inicial de aptidão física e ao estresse térmico total experimentado pelo indivíduo.

9.10 - RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO

A saúde mental é uma questão fundamental no atual contexto de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, ficando evidente a importância das organizações abordarem os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.

A Área de Saúde Ocupacional tem como papel prevenir o adoecimento mental dos trabalhadores, primando pela qualidade de vida integral deles, através de ações de vigilância de saúde passivas (palestras e campanhas) e ativas (rastreamento, detecção precoce dos agravos à saúde mental e tratamento oportuno).

Ações para atenuar e/ou mitigar os riscos psicossociais identificados:

- Integração da NR 1 no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - GRO: Inclusão dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos PGR e no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO, estabelecendo planos de ações específicos para os riscos psicossociais relacionados ao trabalho identificados.
- Reorganização do Trabalho: Ajuste de cargas de trabalho para níveis sustentáveis, com definição transparente dos papéis e funções, orientações claras e objetivas sobre as rotinas de trabalho, assim como, proporcionar maior autonomia aos trabalhadores sobre suas tarefas e atividades.
- Capacitação de líderes: Treinamento de gestores para identificar sinais de adoecimento psíquico nos trabalhadores, promovendo um ambiente psicologicamente seguro, utilizando uma linguagem assertiva, empática, clara e voltada para o acolhimento e gerenciamento de conflitos.
- Políticas e Canais de Denúncia: Implementação e divulgação de políticas rigorosas contra assédio moral, sexual, entre outras formas de assédio, com a criação de canais de denúncia anônimos e seguros.
- Gestão Participativa: Incentivo à participação dos trabalhadores nas questões inerentes às suas atividades de trabalho.
- Prevenção e Promoção de Saúde Mental no Trabalho: Disponibilização de materiais educativos e didáticos aos trabalhadores, e viabilização de campanhas relacionadas ao tema.
- Apoio à Saúde Mental: Oferecimento de programas de assistência ao colaborador e apoio psicológico, com escuta qualificada, caso o trabalhador necessite.

Essas intervenções devem ser contínuas, com monitoramento da eficácia das medidas propostas, através de pesquisas de clima organizacional e análise de indicadores de absenteísmo e presenteísmo, pelas empresas.

O monitoramento da saúde mental dos trabalhadores da construção é muito importante porque assegura o cumprimento das normas regulamentadoras, especialmente, a NR 1, assim como, reafirma o compromisso das empresas a zelar, pela qualidade de vida integral de seus trabalhadores, proporcionando um ambiente de trabalho seguro e saudável.

O corpo clínico ocupacional do Seconci Goiás, através de ferramentas adequadas e cientificamente validadas, realizará o monitoramento individual de cada trabalhador exposto ao risco psicossocial relacionado ao trabalho. Este monitoramento servirá de subsídio para a melhoria contínua dos PGR s, favorecendo a criação de um plano de ação individual e assertivo para cada empresa, assim como, para cada trabalhador atendido.

Todos os colaboradores expostos a risco psicossocial realizarão, em avaliação médica ocupacional, um teste de triagem, SRQ20- Self Report Questionnaire. Questionário este, cancelado pela OMS para rastreamento de sofrimento mental.

Nos casos de exposição ao risco psicossocial, classificados como moderados e acima deste, associados ou não à atividades críticas (trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, operação de máquinas pesadas), além da avaliação médica de saúde mental, o colaborador realizará avaliação psicossocial com um(a) psicólogo(a), nos exames admissionais, periódicos, mudança de riscos ocupacionais, ou quando, a avaliação clínica ocupacional exigir.

Ressaltamos, que estas iniciativas são de grande importância na gestão de afastamentos de patologias psiquiátricas, uma das mais relevantes e prevalentes causas de afastamento previdenciário, atualmente, no Brasil.

10 - DOCUMENTOS

10.1 - Prontuário médico.

Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a empresa estiver dispensada de PCMSO.

O prontuário do empregado deve ser mantido pela empresa, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a empresa deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor.

Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que sejam atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina.

10.2 - Relatório Analítico do PCMSO.

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados;
- b) o número e tipos de exames complementares realizados;
- c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela empresa, referentes aos empregados;
- f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

A empresa deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso.

Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico.

O Relatório Analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da empresa, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na empresa.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados, podem elaborar Relatório Analítico apenas com as seguintes informações: número de exames clínicos realizados; número e tipos de exames complementares realizados.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	22/09/2026
---	--	---

Unidade: GPL - SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

GHE 01 - BETONEIRA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Operador de Betoneira		
Opera a betoneira, faz concretos quando necessário, prepara massa para serviços diversos de acordo com traços especificado em sua instrução de trabalho, preenche o Checklist diário. Registra e comunica alterações no funcionamento da máquina e acompanha quando houver manutenção.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	Irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Aluminato Tricálcico	Químico	A exposição ao pó de cimento e à pasta de cimento pode causar irritações respiratórias, cutâneas, oculares e digestivas, com riscos aumentados em casos de exposição prolongada ou repetida.
Carbonato de Cálcio ppt	Químico	A exposição ao pó de cimento e à pasta de cimento pode causar irritações respiratórias, cutâneas, oculares e digestivas, com riscos aumentados em casos de exposição prolongada ou repetida.
Ferro Aluminato de Cálcio	Químico	A exposição ao pó de cimento e à pasta de cimento pode causar irritações respiratórias, cutâneas, oculares e digestivas, com riscos aumentados em casos de exposição prolongada ou repetida.
Hidróxido de Cálcio	Químico	A exposição ao pó de cimento e à pasta de cimento pode causar irritações respiratórias, cutâneas, oculares e digestivas, com riscos aumentados em casos de exposição prolongada ou repetida.
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Silicato dicálcico	Químico	A exposição ao pó de cimento e à pasta de cimento pode causar irritações respiratórias, cutâneas, oculares e digestivas, com riscos aumentados em casos de exposição prolongada ou repetida.
Silicato tricálcico	Químico	A exposição ao pó de cimento e à pasta de cimento pode causar irritações respiratórias, cutâneas, oculares e digestivas, com riscos aumentados em casos de exposição prolongada ou repetida.
Sulfato de cálcio	Químico	A exposição ao pó de cimento e à pasta de cimento pode causar irritações respiratórias, cutâneas, oculares e digestivas, com riscos aumentados em casos de exposição prolongada ou repetida.
Óxido de Cálcio (livre)	Químico	A exposição ao pó de cimento e à pasta de cimento pode causar irritações respiratórias, cutâneas, oculares e digestivas, com riscos aumentados em casos de exposição prolongada ou repetida.

Óxido de Magnésio (livre)	Químico	A exposição ao pó de cimento e à pasta de cimento pode causar irritações respiratórias, cutâneas, oculares e digestivas, com riscos aumentados em casos de exposição prolongada ou repetida.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e Equipamentos (Betoneira)	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 02 - ARMAÇÃO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Armador Faz as estruturas conforme projeto, para colocação nas formas de pilares, vigas e lajes. Coloca os espaçadores. Auxilia no transporte dos aços até às baias. Faz a separação dos resíduos para reciclagem. Somente os armadores capacitados fazem o uso do policorte. Eventualmente os operadores de policorte cortam e dobram o aço.		
Cargo: Encarregado de Armação Coordena todo serviço referente à armação como: Eventuais cortes e dobra dos aços e estruturais conforme projeto, para colocação nas formas de pilares, vigas e lajes, transporte dos aços até às paia, separação dos resíduos para reciclagem.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	22/09/2026
--	---	-------------------

Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Poeiras metálicas	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Movimentos repetitivos	Ergonômicos	Pode causar lesões como tendinites, bursites e síndromes de compressão de nervos.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 03 - CARPINTARIA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho

Cargo: Carpinteiro		
Confecciona as formas de pilares, vigas e lajes, usando chapa de madeira compensada. Faz a montagem das torres de sustentação da laje, monta e regula usando os escoramentos metálicos nos pilares. Colocação de corrimão provisório nas escadas. Proteções coletivas de madeira e cabo de aço, faz a desforma usando a sequência: pilares, vigas e lajes. Eleva os materiais para o piso superior para início de novo ciclo. Somente os carpinteiros capacitados fazem o uso da serra circular de bancada.		
Cargo: Encarregado de Carpintaria		
Planejam e supervisionam montagem e desmontagem de forma e escoramento, baldrames, pilares, vigamento lajes e etc, Supervisão de atividades como: instalação de corrimão provisório nas escadas, construção de proteções coletivas de madeira, execução de desmonte de andaime, limpeza do local de trabalho, operação de serra circular e ferramentas manuais		
Cargo: Meio Oficial de Carpinteiro		
Auxilia todas as atividades da carpintaria na obra. Confecção de formas, desformas, escoramento, limpeza. Outros serviços ligados à carpintaria.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeira da madeira (vegetal NHO 08)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Óleos vegetais e ácidos graxos emulsionados	Químico	Irritações dérmicas e Oculares leves.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA		22/09/2026
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 04 - PRODUÇÃO 01

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Meio oficial de pedreiro		
Auxilia o pedreiro na compactação e aterro, concretagem, alvenaria estrutural, marcação de alvenaria, alvenaria, assentamento de talisca, impermeabilização com cimento polimérico, contrapiso, instalação de contra marco, reboco interno e externo, assentamento de bancada, piso e revestimento cerâmico, revestimento cerâmico em fachada, revestimento de fachada em pastilha cerâmica, revestimento em pedra.		
Cargo: Pedreiro		
Faz compactação e aterro, concretagem, alvenaria estrutural, marcação de alvenaria, alvenaria, assentamento de talisca, impermeabilização com cimento polimérico, contrapiso, instalação de contramarco, reboco interno e externo, assentamento de bancada, piso e revestimento cerâmico, revestimento cerâmico em fachada, revestimento de fachada em pastilha cerâmica, revestimento em pedra.		
Cargo: Servente		
Carregamento e descarregamento de materiais, manual ou por meio de girica, auxilia nas frentes de produção. Limpeza geral em todas as frentes de serviços e outros locais na obra, remoção de resíduos para lixo, separa materiais recicláveis e outros serviços braçais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
2-metil-2H-isotiazole-3-ona(3:1)	Químico	Pode provocar reações alérgicas na pele
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Químico	Pode provocar reações alérgicas na pele
Copolímero de estireno e butadieno (Risco classificado como baixo no PGR)	Químico	Irritações dérmicas e oculares leves.
Metiltriacetóxissilano	Químico	pode provocar irritação das vias respiratórias, ocular e dermica

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	22/09/2026
Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos	Químico	pode causar irritação nas vias respiratórios, ocular e dermica	
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	
Polidimetilsiloxano	Químico	pode provocar irritação das vias respiratórias, ocular e dermica	
Selante - Dióxido de titânio	Químico	Irritações dérmicas e oculares leves.	
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 05 - LIMPEZA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais		
Faz limpeza de refeitório, lava pratos após o almoço, limpeza e organização das mesas e cadeiras, limpeza dos sanitários e salas da administração		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Hipoclorito de Sódio 1%	Químico	Irritação moderada na pele e irritação severa nos olhos, por contato direto e irritação das vias aéreas superiores por inalação
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Produtos domissanitários	Químico	Irrigação leve na pele e moderada nos olhos
Agentes patogênicos	Biológico	Infecções em geral
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 06 – CREMALHEIRA

O profissional desempenha suas atividades em um ambiente semiaberto, no qual pode utilizar tanto a iluminação e ventilação natural quanto a artificial, conforme necessário

Cargo: Operador de elevador tipo cremalheira		
Opera o elevador de cremalheira, fazendo movimentação de pessoas e materiais diversos para atender todas as frentes de trabalho, sendo proibido o transporte simultâneo deles. Desce todos os tipos de resíduos. Faz o preenchimento diário do checklist do elevador de cremalheira, registra e comunica alterações no funcionamento do elevador e acompanha quando houver manutenção.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (corpo inteiro)	Físico	Efeitos adversos na coluna vertebral, devido à exposição à VCI, como lombalgia, degeneração precoce da região lombar e hérnia de disco, dores musculares, náuseas, entre outros.
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1075) Radiografia de coluna lombo-sacra	X				X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 07 – SEGURANÇA DO TRABALHO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Auxiliar de Técnico em Segurança do Trabalho

Auxilia o técnico de segurança na realização dos treinamentos de integração e na implantação da CIPA e reuniões ordinárias. Orienta os funcionários dos riscos existentes no canteiro. Faz o DSS, inspeciona e conscientiza o uso de EPI/EPC. Mantém as planilhas atualizadas de exames médicos, de mão de obra própria e terceiros. Faz conferência dos documentos de terceiros para adentrar ao canteiro. Acompanha a inspeção de todo o canteiro.

Cargo: Coordenador de segurança do trabalho

Supervisiona as ações do SESMT de todos os canteiros. Orienta a comunicação prévia de obras. Fiscaliza os serviços terceirizados ligados à Segurança do Trabalho como PGR, PPP, PCMSO, LTCAT. Auxilia nas inspeções de documentos terceirizados. Ministra treinamentos admissionais, e outros necessários. Orienta o processo de CIPA e curso de CIPA. Inspecciona os serviços de proteções coletivas. Faz auditorias nas obras. Faz DSS. Confecciona a documentação da segurança e repassa ao SGQ para análise e publicação no AUTODOC.

Cargo: Estagiário de Segurança do Trabalho

Auxilia nas atividades de segurança do trabalho, acompanha vistoria no canteiro. Preenchimento de ficha de EPI. Acompanha controle de vacinas, exames e treinamento, acompanha a liberação de serviços, Balancim e concretagem. Auxilia na sinalização segurança do canteiro de obra, auxiliar nos agendamentos de exames médicos, auxilia no preenchimento de checklist.

Cargo: Técnico em Segurança Do Trabalho

Responsável técnico pelo SESMT da obra. Orienta os funcionários dos riscos existentes no canteiro. Faz o DSS, inspeciona e conscientiza o uso de EPI/EPC, faz treinamento de, Integração. Mantém as planilhas atualizadas de exames médicos, de mão de obra própria e terceiros. Implantação da CIPA e coordena as reuniões ordinárias, faz conferência dos documentos de terceiros para adentrar ao canteiro. Inspecciona todo o canteiro.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.

 PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA			22/09/2026
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 08 – SUPERVISÃO DE EQUIPES

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Encarregado de Abastecimento		
Planejam e supervisionam os serviços de abastecimento de materiais para as frentes de serviço.		
Cargo: Encarregado de Elétrica		
Planejam e supervisionam os serviços de instalações elétricas em geral.		
Cargo: Encarregado de hidráulica		
Planejam e supervisionam os serviços de instalações hidráulicas em geral.		
Cargo: Encarregado de Instalações		
Planejam e supervisionam os serviços de instalações hidráulicas e elétricas		
Cargo: Encarregado de Obra		
Planeja e supervisiona os serviços gerais da obra		
Cargo: Mestre de obras		
Supervisiona as atividades da obra na fundação, estrutura e acabamento. Responsável pela realização de todos os serviços descritos no Projeto. Administração geral do canteiro. Inspecciona os serviços que estão sendo executados, solicita a organização e limpeza do canteiro		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 09 – ADMINISTRAÇÃO

Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.

Cargo: Administrativo de Obras

Responsável pelo Recursos humanos da empresa. Pedidos de insumos mantem contato com fornecedores. Fechamento de folha de ponto. Auxilia o engenheiro da obra em outras atividades da administração. Mantém contato com o escritório central. Faz o registro nas CTPS.

Cargo: Jovem Aprendiz (maior ou igual a 18 anos)

Auxilia no recebimento de notas, receber materiais, auxilia no controle de batidas de ponto e fechamento de ponto, e auxilia outros departamentos, dependendo de onde está lotado.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 10 – ALMOXARIFADO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do almoxarifado e em campo.

Cargo: Almoxarife

Responsável pelo recebimento e conferência dos insumos de acordo com sua instrução de trabalho. Mantém o controle de estoque. Organiza e sinaliza os tipos de materiais. Lança planilha de compras. Mantém o controle das máquinas e equipamentos da empresa e locados. Auxilia e coordena a entrega de ferramentas e EPIS. Supervisiona e orienta os serviços dos jovens aprendizes.

Cargo: Auxiliar de Almoxarife

Auxilia o almoxarife no pelo recebimento e conferência dos insumos de acordo com sua instrução de trabalho. Mantém o controle de estoque. Organiza e sinaliza os tipos de materiais. Auxilia e coordena a entrega de ferramentas e EPIS.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infeções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 11 – ENGENHARIA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Quando na administração, pé direito de aproximadamente 3m, ventilação e iluminação artificial”.

Cargo: Assistente de Engenharia Civil		
Auxilia a engenharia em todas as atividades pertinentes à obra, projetos, documentos, orçamentos, contratação de terceiros e outras atividades ligadas à administração da obra. Faz medições e orienta os encarregados sobre determinadas atividades. Na ausência do engenheiro Ele responde pela obra.		
Cargo: Auxiliar de Engenharia Civil		
Auxilia o engenheiro da obra nas atividades de engenharia, realiza verificação de FVS. Auxilia nas medições de serviços terceirizados, Realiza conferência de serviços. Acompanha as atividades, verificando in loco de acordo com o projeto.		
Cargo: Engenheiro civil		
Responsável Técnico pela execução da obra, faz verificação de serviços e acompanhamento de execução. Faz orçamentos de serviços de terceiros. Contrata serviços, autoriza compra de insumos diversos, autoriza e solicita pagamentos. Verifica quais materiais serão usados na obra especificado no projeto, acompanha o cronograma da obra.		
Cargo: Estagiário de Engenharia Civil		
Auxilia o engenheiro da obra nas atividades de engenharia, realiza verificação de FVS. Auxilia nas medições de serviços terceirizados, Realiza conferência de serviços. Acompanha as atividades, verificando in loco de acordo com o projeto.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA		22/09/2026
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 12 – MAQUINAS

O profissional atua em diversas áreas da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação variam. Na cabine, é fundamental que haja janelas amplas para garantir boa visibilidade e sistemas de ar condicionado e aquecimento, mantendo a temperatura confortável durante o trabalho.

Cargo: Operador de Máquinas		
Operação de máquinas e equipamentos.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONTRIBUINDO ÀS TRANSFORMAÇÕES	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	22/09/2026
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infeções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

GHE 13 – PORTARIA

O profissional exerce suas funções em um ambiente semiaberto, no qual o pé direito possui aproximadamente 3 metros de altura, proporcionando adequada ventilação e iluminação natural.

Cargo: Porteiro

Recebe os visitantes, se for cliente encaminha à sala de atendimento ao cliente, comunica com a obra, via rádio, da chegada de insumos, Faz a limpeza da calçada, organiza o trânsito no local. Orienta outros visitantes que adentram ao canteiro de obras, faz registro no controle diário de visitantes e lista de colaboradores de empreiteiros com entrada permitida na obra

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como diabetes e doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Violência Física	Acidente	Lesões superficiais, traumas e hemorragias.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	

GHE 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DESENERGIZADO

O profissional exerce suas atividades em diferentes áreas da obra, onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar conforme o ambiente de trabalho. As tarefas podem ser realizadas tanto em locais fechados quanto abertos no canteiro de obras.

Cargo: Eletricista		
Fixa caixa ortogonal e conduites na laje a ser concretada para, posteriormente, passagem de enfição. Corta paredes para passagens de mangueiras e fixação das caixas metálicas retangulares. Passa enfição dentro das mangueiras e dentro dos apartamentos. Faz a ligação na central geral de cada apartamento. REALIZA OS TRABALHOS ANTES DA REDE SER ENERGIZADA		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.
--------------------	-----------------	---

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 16 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

O profissional realiza suas atividades em local coberto (pé direito de aproximadamente 3m), piso nivelado, local isolado para a atividade com ventilação natural e iluminação natural e artificial.

Cargo: Encanador

Fixar as caixas de passagens de acordo com as medidas do projeto hidro sanitário, desobstruir e ajustar as passagens na laje de concreto, instalar tubulações, fixando-a nos prolongamentos chumbados nas lajes e amarrando-a no teto e nos pontos onde for necessário, fixando com argamassa de assentamento. Fazer a ligação da tubulação à prumada e chumbar os registros nas paredes. Fazer a limpeza do local ao finalizar.

Cargo: Encarregado de encanador

Acompanhamento dos serviços na execução de projetos de instalação hidrossanitários definitivos e instalações provisórias do canteiro, fechamento de FVS, recebimento de serviços. Acompanhamento na marcação de tubulação de laje para concretagem.

Cargo: Meio Oficial de Encanador

Auxilia o encanador em todas as atividades de colocação de canos nos banheiros, corte, retira os canos marcação nas lajes

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Acetato de etila	Químico	Se inalado causa: Dor de garganta. Tosse. Dor de cabeça. Sonolência. Provoca irritação ocular grave Provoca irritação cutânea
Acetona (Risco classificado como baixo no PGR)	Químico	Se inalado pode provocar: Dor de garganta. Tosse. Dor de cabeça. Tonturas. Confusão. Sonolência. Perda de consciência. Provoca irritação ocular grave Provoca irritação moderada da pele

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	22/09/2026
Bisfenol A epoxi resina, peso molecular médio >700-1100	Químico	Provoca irritação ocular grave. Provoca irritação á pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Rritante para a boca, a garganta e o estomago.
Ciclohexanona (Risco classificado como baixo no PGR)	Químico	Se inalado pode provocar: Dor de garganta. Tosse. Dor de cabeça. Tonturas. Confusão. Sonolência. Perda de consciência. Provoca irritação ocular grave Provoca irritação moderada da pele
Dibutilftalato	Químico	Provoca irritação ocular grave. Provoca irritação á pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Rritante para a boca, a garganta e o estomago.
Metiletilcetona (Risco classificado como baixo no PGR)	Químico	Se inalado pode provocar: Tosse. Dor de cabeça. Tonturas. Náuseas. Vômitos. Sonolência. Dormência. Respiração ofegante. Provoca irritação ocular grave Pode causar perda de consciência se inalado
Metiltriacetóxisilano	Químico	pode provocar irritação das vias respiratórias, ocular e dermica
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Tetrahidrofurano (Risco classificado como baixo no PGR)	Químico	Se inalado pode provocar: Tosse. Sensação de queimadura na garganta e no peito. Tonturas. Dor de cabeça. Náuseas. Perda de consciência.. Provoca irritação ocular grave Provoca irritação moderada da pele Pode ser nocivo para o rins e fígado após exposição prolongada ou repetida Suspeito de provocar cancro
Etiltriacetoxissilano	Químico	Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento e aos olhos com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca anorexia, dificuldade de concentração, disfunção auditiva, distúrbio do sono e distúrbio visual.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 17 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESENERGIZADO)

O profissional exerce suas atividades em diferentes áreas da obra, onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar conforme o ambiente de trabalho. As tarefas podem ser realizadas tanto em locais fechados quanto abertos no canteiro de obras.

Cargo: Eletricista - Manutenção		
Montagem e ampliação de instalação elétrica provisória. Troca de tomadas defeituosas. Interruptores e demais elementos da instalação elétrica. Teste de tensão. Montagem dos Robôs nos pavimentos com supervisão do encarregado. Instalação geral dos circuitos das máquinas. Realiza teste de continuidade na instalação elétrica a fim de garantir a alimentação elétrica correta de todos os elementos instalados. Instalação dos quadros elétricos e de medição. A ENERGIA É DESLIGADA PARA INTERVENÇÕES ELÉTRICAS, EM ATENDIMENTO A NR-10, E O PROCEDIMENTO INTERNO		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração Localizadas (Mão- Braço)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

 SECONCI ÓRGÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA		22/09/2026
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.	
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Máquinas e equipamentos	Acidente	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 18 - ADMINISTRAÇÃO 02

Trabalho realizado dentro do escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3M iluminação e ventilação artificial.

Cargo: Menor Aprendiz (Trabalho realizado exclusivamente dentro do escritório da construtora, não atua na obra)

Auxilia no recebimento de notas, receber materiais, auxilia no controle de batidas de ponto e fechamento de ponto, e auxilia outros departamentos, dependendo de onde está lotado.

Perigo / Fator de Risco

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

GHE 19 - ADMINISTRAÇÃO 03

Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.

Cargo: Auxiliar de plantão

Recepção de clientes e atendimento ao público

Cargo: Recepcionista

Recepção de clientes e atendimento ao público

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível

Radiação não ionizante	Físico	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Poeira total e Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 20 - OPERAÇÃO DE GRUA

O profissional atua em diversas áreas da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação variam. Na cabine, é fundamental que haja janelas amplas para garantir boa visibilidade.

Cargo: Operador de grua		
Opera e avalia as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel. Organizam cargas para transporte até os pavimentos destinados		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)

Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.
Corte e Perfuração	Acidente	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias
Queda de mesmo nível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

GHE 21 - LIMPEZA INTERNA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais		
Faz limpeza de refeitório, lava pratos após o almoço, limpeza e organização das mesas e cadeiras e salas da administração, exceto serviços de limpeza de banheiros e áreas com riscos biológicos.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Produtos domissanitários	Químico	Irritação leve na pele e moderada nos olhos
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Relações interpessoais	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	22/09/2026
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X				X	

GHE 22 - SERRALHERIA

Setor separado especificamente para serviço de serralheria em ambiente bem ventilado.

Cargo: Soldador		
Confecção de peças metálicas, soldagem. Uso de ferramentas: Policorte, lixadeira, máquina de solda.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Fumos metálicos (cobre)	Químico	Irritação de vias aéreas superiores, gosto metálico, tosse e desconforto respiratório; possibilidade de agravos respiratórios em exposições prolongadas.
Fumos metálicos (cromo)	Químico	Irritação de pele e mucosas, sensibilização respiratória e cutânea; risco aumentado de câncer de pulmão e de seios nasais nas exposições a compostos de cromo VI.
Fumos metálicos (ferro)	Químico	Irritação de vias respiratórias e possibilidade de siderose pulmonar em exposições elevadas e prolongadas; sintomas respiratórios como tosse e dispnéia em concentrações elevadas.
Fumos metálicos (manganês)	Químico	Sintomas agudos como febre dos fumos de solda, tontura, náusea e irritação de vias aéreas; em exposições crônicas, efeitos neurotóxicos sobre o sistema nervoso central e agravos respiratórios.
Comportamentos ofensivos	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Conflitos família e trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Demandas no trabalho	Ergonômicos	Transtorno mental; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Ergonômicos	Lesão musculoesquelética para a coluna vertebral.
Influência e desenvolvimento	Ergonômicos	Transtorno mental; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)
Liderança	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Postura de pé por longos períodos	Ergonômicos	Dores lombares ou lombalgias que podem desenvolver graves lesões da coluna.
L	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Satisfação no trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Significado e compromisso	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Valores no local de trabalho	Ergonômicos	Transtornos mentais.
Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Acidente	Lesões de tecidos moles, feridas e abrasões, perfurações e outras.
Pisos, passagens, passarelas, plataformas, rampas e corredores com saliências, descontinuidades, aberturas ou obstruções ou escorregadios	Acidente	Fraturas e contusões diversas.
Queda de objetos	Acidente	Perfurações, contusões diversas, traumatismo craniano, mortes e outros.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	22/09/2026
---	--	--

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0289) Avaliação Médica de Saúde Mental	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0467) Cromo Urinário		6 meses	6 meses		X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0836) Manganês Sanguíneo	X	6 meses	6 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

11. PROGRAMA DE VACINAÇÃO

A vacina é uma das principais aliadas do Serviço de Saúde Ocupacional porque permite, a partir de ações simples e de baixo custo, integrar o conjunto de medidas preventivas dos Programas de Saúde Ocupacional a serem implantados, com diminuição do risco de absenteísmo.

Além disso, é um programa que assegura a prevenção de doenças que interferem na capacidade produtiva, evitando faltas, licenças temporárias por motivos de doenças e as aposentadorias precoces.

De acordo com as características do trabalho na Indústria da Construção, orienta-se à empresa exigir a apresentação do comprovante da Vacina Antitetânica (Dupla adulto), e da vacina contra Febre amarela, na admissão do colaborador. De acordo com as características do trabalho na Indústria da Construção, orienta-se à empresa exigir a apresentação do comprovante da Vacina Antitetânica (Dupla adulto), e da vacina contra Febre amarela, na admissão do colaborador.

Recomenda-se que sejam aplicadas as vacinas conforme PNI (Plano Nacional de Imunização) do Ministério Saúde, do ano vigente. Além, disso, orienta-se que seja tomada em conta o "calendário de vacinação ocupacional da Sociedade Brasileira de Imunizações-SBIm Ocupacional, disponível no site: <http://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-ocupacional.pdf>.

Orienta-se também que a empresa mantenha junto ao ASO admissional, cópia do cartão de vacinação atualizado.

VACINAS RECOMENDADAS	DOSAGENS E INTERVALOS
Dupla Adulto	Três doses em não vacinados => 0, 60 e 120 dias (e reforço a cada 10 anos) Observação: esquema diferenciado para gestante
Influenza	Dose única anual
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19
Febre Amarela	Dose única Recomendação da SBIm: como não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina; de acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose em outras idades podem ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.

SALAS DE VACINAS

As vacinas são encontradas na rede pública de saúde, segue lista de postos de vacinação em Goiânia:

DISTRITO NORTE

UNIDADE	ENDEREÇO	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
CIAMS URIAS MAGALHAES	Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães	TODOS OS DIAS 08h às 18h
CS BENEDITO DOS SANTOS VIEIRA	Av. Perim, 404 - St. Perim	08h às 12h
USF GUANABARA I	Rua Porto Alegre, Qd 13-A, Lt 1 Jd Guanabara I.	08h às 17h
CS JARDIM BALNEARIO MEIAPONTE	Rua dos Paranaenses, esquina com Rua dos Gaúchos Qd. F-7 Nº 733 - Jd. Balneário Meia Ponte	13h às 17h
CS VILA CLEMENTE	Rua dos Tamoios, Qd 06, Lt 03 e 04, Vila Clemente	08h às 17h
USF CACHOEIRA DOURADA	Rua Cachoeira Dourada Qd. 86 Lt. 08 -Jd. Guanabara I	08h às 17h
USF ITATIAIA	R. R-12, s/n - Conj. Itatiaia	08h às 17h
USF MORADA VALE DOSSONHOS	Rua Maria de Jesus Qd 56 Lt 12,Residencial Vale dos Sonhos	08h às 17h
USF ANTONIO CARLOS PIRES	R. ACP 4 - Res. Antônio Carlos Pires, Goiânia - GO, 74690-300	08h às 17h
USF SÃO JUDAS TADEU	Avenida Brasília esquina com Rua Santana Qd. 30 - Vila Jardim São Judas Tadeu	08h às 17h

DISTRITO SUL

UNIDADE	ENDEREÇO	FUNCIONAMENTO
UPA DR DOMINGO VIGGIANO - JARDIM AMERICA	Praça C-201, S/N , Jardim América	TODOS OS DIAS 08h às 18h
CMV - CENTRO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO ORIENTAÇÃO AO VIAJANTE	Av. Edmundo P. de Abreu, s/n - St. Pedro Ludovico	TODOS OS DIAS 08h às 18h
CS HORTÊNCIA MENDONÇA VILA REDENÇÃO	Alameda Emilio Póvoa, n. 151 – Vila Redenção	08h às 17h
CS PARQUE AMAZÔNIA	Praça José Rodrigues de Moraes, Av. Sen. José Rodrigues de Moraes Neto, n - Parque Amazônia	08h às 17h

DISTRITO LESTE

UNIDADE	ENDEREÇO	FUNCIONAMENTO
CS DR AFONSO HONORATO DA SILVA E SOUZA	Rua 01 Qd.E Lt.08 - Setor Água Branca	08h às 17h
CAIS PARQUE DAS AMENDOEIRAS	Av Francisco Ludovico de Almeida Qd.24 s/n Setor - Parque das Amendoeiras	13h às 18h
USF RIVIERA	Avenida Liberdade com Rua 18, APM 08, Conjunto Riviera	08h às 17h
USF JARDIM DOM FERNANDO	Rua 218 esquina com Rua 217, Qd.30 - Jardim Dom Fernando II	08h às 17h
USF PARQUE ATHENEU	Avenida Parque Atheneu, Lt(s) 16 e 18 unid. 201, Parque Atheneu	08h às 17h
USF RECANTO DAS MINAS GERAIS MILITAO R DE ARAUJO	Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena	08h às 17h
USF SANTO HILÁRIO	Rua Juscelino da Fonseca Ribeiro Qd. 14 Lt. 09, Bairro Santo Hilário	08h às 17h
USF VILLE DE FRANCE	Rua Pires Figueiredo Qd.4 Lt. 03 APM 06 Res. Ville de France	08h às 17h
UPA DR. DE SIQUEIRA GARCIA (CHÁCARA DO GOVERNADOR)	Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador	08h às 18h
UPA JARDIM NOVO MUNDO	Avenida New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo	08h às 18h

DISTRITO OESTE

UNIDADE	ENDEREÇO	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
CS BAIRRO GOIA	Av. Santa Maria S/N Chácara Santa Rita - Bairro Goiás	08h às 17h
CS PARQUE INDUSTRIAL JOÃO BRAZ	Rua Rodrigues Alves esq. com Rua Olímpia quadra 52 lts.14 e 15 Pq. Industrial	08h às 17h
USF BUENA VISTA	Rua João Amoreles Quadra Apm II Lote Zero, Residencial Buena Vista I	08h às 12h
USF ELDORADO OESTE	Rua Elo-22 Qd. 22 Lt.35, Parque Eldorado Oeste	08h às 17h
USF GOIÂNIA VIVA	Rua GV 17 - A Qd. 46, Casa da Chácara Taquaral, Reserva Ecológica do Residencial Goiânia Viva	08h às 17h
USF JARDIM CERRADO IV	Rua Pingo De Ouro - Jardim Cerrado 4	08h às 17h
USF JARDIM CERRADO VI	Rua JC-204 APM-3 Jd. Cerrado 6	08h às 12h
USF PARQUE DOS BURITIS	R. Rosimira Marques, s/n - Parque Buritis	08h às 12h
USF SÃO FRANCISCO	Avenida das Palmeiras, quadra 89, lote 10. Bairro São Francisco	08h às 17h
USF VERA CRUZ I	R. Eunice Weaver - Conj. Vera Cruz	08h às 17h
USF VERA CRUZ II	Av. Leopoldo de Bulhões, s/n, Conj. Vera Cruz II	08h às 17h
USF VILA REGINA	R. São Miguel, 189 - Vila Regina	08h às 13h

SALAS DE VACINAS

DISTRITO NOROESTE

UNIDADE	ENDEREÇO	FUNCIONAMENTO
CAIS CÂNDIDA DE MORAIS	Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº - Setor Cândida de Moraes	08h às 18h
USF BOA VISTA	Av. dos Ipês quadra 02 lote area bairro Boa Vista	08h às 17h
USF BRISAS DA MATA	Rua BM10 Quadra 21 Lote 62 Residencial Brisas da Mata	08h às 17h
USF ESTRELA DALVA	Rua 16 de maio Qd.4-B Lt.32, Setor Estrela Dalva	08h às 17h
CAIS FINSOCIAL	Rua VF- 64 Qd.49 - Setor Finsocial	08h às 18h
USF JARDIM CURITIBA I	Rua JC22 Area Verde Jardim Curitiba I	08h às 17h
USF JARDIM PRIMAVERA	Rua CP - 38 Qd. 47, Lt 1 a 3 Jardim Primavera	08h às 12h
USF NOVO PLANALTO	Rua Vm Três E quadra 95 – St. Novo Planalto	08h às 17h
USF ALTO DO VALE (RECANTO DO BOSQUE)	Rua VF-9 com Rua Samir, Qd. área s/n, Setor Alto do Vale	08h às 17h
USF SÃO CARLOS	Rua SC-27 com a Rua SC-46, Qd.84-A, AMP 11, Bairro São Carlos	08h às 17h
USF VILA MUTIRÃO	Avenida do Povo Qd. D, Vila Mutirão	08h às 17h

DISTRITO SUDOESTE

UNIDADE	ENDEREÇO	FUNCIONAMENTO
CIAMS NOVO HORIZONTE	Rua, Av. Eng José Martins Fl Q 55, s/n - Vila Novo Horizonte	08h às 17h
CS PARQUE ANHANGUERA	Travessa Machado de Assis, Qd. 2-A, Lts. 1 a 8 - Bairro Parque Anhanguera	08h às 12h
CS JARDIM VILA BOA	Rua Almirante Barroso esquina com Rua Castro Alves S/Nº - Vila Boa	08h às 12h
CS JOSE DO EGIDIO MARTINS - VILA UNIÃO	R. U-47, s/n - Vila União	08h às 17h
USF ANDREIA CRISTINA	Avenida Blumenau Qd. 28 Lt. 176, Setor Andréia Cristina	08h às 17h
USF CONDOMÍNIO DAS ESMERALDAS	Rua 17 s/nº Qd. 39 Lt.04 - Condomínios das Esmeraldas I	08h às 17h
USF ELI FORTE	R. EF 30, 64 - Res. Eli Forte Extensão	13h às 17h
CS VALERIA APARECIDA MARTINS DA SILVA - GARAVELO B	Rua Ciro Manuel Qd 01 Lt 23 Setor Santa Rita 6ª etapa	08h às 12h
USF JARDIM CARAVELAS	R. JCA 12 - Jardim Caravelas	08h às 17h
USF MADRE GERMANA	Av. José Barbosa Dos Reis, Esq. Com Rua Jarina Qd. 53 Lt. 01, Madre Germana II	08h às 17h
USF SANTA RITA	Av. Americano do Brasil s/nº quadra 02 lote 06 Parque Santa Rita	08h às 17h
USF RESIDENCIAL REAL CONQUISTA	R. RC. 51 c/ RC 17 c/ RC 18, Residencial Real Conquista	08h às 17h
USF WALDOMIRO CRUZ RESIDENCIAL ITAIPU	Rua RI 37 esq. com RI 8 e RI 9, Residencial Itaipu	08h às 17h
CS VILA MAUÁ	Av. das Bandeiras Qd. 35 Lts. 11 e 12 - Vila Mauá	08h às 12h

DISTRITO CAMPINAS-CENTRO

UNIDADE	ENDEREÇO	FUNCIONAMENTO
CRA SPI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA	Av. Armando de Godói, 326 - Cidade Jardim	08h às 17h
CS CIDADE JARDIM MICHELLE MUNIZ DO CARMO	Praça Abel Coimbra (ao lado do CSU, na antiga praça da Feira da Cidade Jardim) – Setor Cidade Jardim	08h às 17h
CS CRIMEIA LESTE	Rua Senador Antônio Martins Borges esquina c/ Rua Virgílio Xavier de Barros CRQd. 28 Lt. 09 S/N- Criméia Leste	13h às 17h
CS ESPLANADA DO ANICUNS	Alameda do Progresso esquina com Rua Tirol S/N Qd.02, Setor Esplanada dos Anicuns	08h às 13h
CS FAMA	Rua 10 Nº 76 - Setor Marechal Rondon	13h às 17h
CS MARINHO LEMOS	Av. Armando de Godoy, s/n - Setor Negrão de Lima, Goiânia - GO, 74650-010	08h às 12h
CS NORTE FERROVIÁRIO	Rua 05-A Qd. A-01 Lt.14 - Setor Norte Ferroviário	08h às 17h
CS VILA CANAÃ	Rua Langendoeffer Qd. 01 Lt. 01 S/N - Vila Canaã	08h às 13h
CS VILA MORAES	Rua 09-A Qd.12 Lt. 11 - Vila Moraes	08h às 17h
CAIS VILA NOVA	Av. Industrial Qd. D-13 Lt. 16 e 17 - Setor Vila Nova	08h às 18h
USF CRIMEIA OESTE	Avenida Goiás Norte esquina c/ a Avenida Domingos Lemos do Prado s/n, Setor Criméia Oeste	08h às 17h
USF LESTE UNIVERSITÁRIO	Rua 218 Qd. A - 02 Lote 10, Setor Leste Universitário	08h às 17h
USF VILA SANTA HELENA	Rua 21, Qd 01 Lt 22 e 23, Vila Santa Helena	13h às 17h

12 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM SAÚDE PREVENTIVA

Conforme Art. 169-A da CLT Lei nº 15.377/2026

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente capítulo foi elaborado em atendimento ao disposto no art. 169-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluído pela Lei nº 15.377, de 2 de abril de 2026, que estabelece como obrigação das empresas disponibilizar informações sobre saúde preventiva a seus empregados, promover ações afirmativas de conscientização e orientar sobre o acesso aos serviços de diagnóstico.

Fundamentação complementar:

- Art. 169-A da CLT Lei nº 15.377/2026: Obrigação de informação e conscientização em saúde preventiva
- Portarias e Recomendações vigentes do Ministério da Saúde
- NR-01 Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO/PGR)

2. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e ações sistematizadas para informar, conscientizar e orientar os trabalhadores desta empresa sobre a prevenção do Papilomavírus Humano (HPV), câncer de mama, câncer de colo do útero e câncer de próstata, promovendo cultura organizacional voltada à saúde preventiva e ao diagnóstico precoce, em cumprimento à legislação trabalhista vigente.

3. TEMAS OBRIGATÓRIOS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, as ações de informação e conscientização deverão abranger obrigatoriamente os seguintes temas:

3.1 Papilomavírus Humano (HPV)

- Transmissão, fatores de risco e formas de prevenção
- Importância da vacinação conforme calendário do Ministério da Saúde
- Relação do HPV com o desenvolvimento de cânceres

3.2 Câncer de Mama

- Fatores de risco e sinais de alerta
- Importância do autoexame e do exame clínico
- Periodicidade recomendada para mamografia

3.3 Câncer de Colo do Útero

- Fatores de risco e formas de prevenção
- Importância do exame de Papanicolau (colpo citologia)
- Periodicidade recomendada pelo Ministério da Saúde

3.4 Câncer de Próstata

- Fatores de risco e sinais de alerta
- Importância do PSA e do exame clínico
- Periodicidade recomendada para rastreamento

3.5 Campanhas Oficiais de Vacinação

- Divulgação das campanhas nacionais vigentes promovidas pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde
- Incentivo à atualização do cartão de vacinação de todos os trabalhadores

4. AÇÕES E ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

A empresa adotará as seguintes estratégias para cumprimento das obrigações legais:

Ação	Responsável	Periodicidade	Registro
Distribuição de material informativo (cartilhas, folders, murais)	RH	Contínuo	Lista de entrega
Envio de comunicados internos (e-mail, aplicativo ou mural)	RH	Contínuo	Evidências físicas ou digitais
Palestras, rodas de conversa, DDS ou treinamentos sobre saúde preventiva	Profissional de Segurança do Trabalho	Contínuo	Lista de presença
Registro e arquivamento das ações realizadas	Profissional de Segurança do Trabalho / RH	Contínuo	Pasta em arquivo

SUGESTÃO DE MATERIAIS

Diante da obrigatoriedade de cumprimento da nova legislação pelas empresas, o Seconci promoveu adequações no modelo de PCMSO e disponibilizará materiais informativos no site da instituição, assim como, ofertará palestras sobre os temas supracitados, através do nosso Comercial.

Segue o passo a passo para acessar aos arquivos no site:

1. Acesse o site do Seconci Goiás;
2. Vá até o menu Portal da Empresa;
3. Selecione a aba Campanhas;
4. Clique em Acessar Campanhas (uma nova aba será aberta);
5. Localize e clique na pasta Programa de Conscientização Em Saúde Preventiva;
6. Navegue pela pasta para baixar os materiais referente à Lei 15337.

13.1 - AÇÕES DO PROGRAMA (CRONOGRAMA)

EMPRESA: SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA														
Local: MEDITERRANÊ														
MÊS ANO	JUL 2026	AGO 2026	SET 2026	OUT 2026	NOV 2026	DEZ 2026	JAN 2027	FEV 2027	MAR 2027	ABR 2027	MAI 2027	JUN 2027	JUL 2027	OBSERVAÇÕES
1 – Exames Médicos Ocupacionais														Realizados no Seconci-GO, agendados pela empresa.
2 – Palestras				X					X					Terão carga horária de 1 hora e serão ministradas no canteiro de obras.
3 – Elaboração de Relatório Analítico													X	Médico Responsável Pelo PCMSO

OBS: Importante justificar com antecedência mínima de 10 dias úteis, qualquer impossibilidade de realização das palestras agendadas pelo SECONCI-GO no email segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br
O cancelamento sem aviso prévio implicará em ressarcimento das despesas com o palestrante e o deslocamento.

13.2 - PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES

MÊS/ANO	TEMA	Carga Horária	Local:	Horário	Palestrante
OUT/26	Noções básicas sobre TÉTANO	1 hora	Locais de Trabalho		
MAR/27	Noções básicas sobre ERGONOMIA	1 hora	Locais de Trabalho		
A critério da obra até JUL/27	Papilomavírus Humano (HPV)	1 hora	Locais de Trabalho		
A critério da obra até JUL/27	Câncer de Mama	1 hora	Locais de Trabalho		
A critério da obra até JUL/27	Câncer de Colo do Útero	1 hora	Locais de Trabalho		
A critério da obra até JUL/27	Câncer de Próstata	1 hora	Locais de Trabalho		
A critério da obra até JUL/27	Vacinação	1 hora	Locais de Trabalho		

OBS: Todas as Palestras serão registradas em lista de presença assinada pelos participantes.
Os temas sugeridos poderão sofrer alterações conforme necessidade constatada.

14. SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Todo estabelecimento deve estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida, sob cuidados de pessoa treinada para este fim.

Nas frentes de trabalho, o material referido no subitem abaixo, ficará sob os cuidados da pessoa treinada para esse fim.

O empregador deve garantir a remoção do acidentado em caso de urgência, sem ônus para o trabalhador.

Reforça-se que em caso de urgências e emergências, deve-se designar um colaborador para acionar SAMU -192 ou Corpo de Bombeiros-193.

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
Materiais		Quantidade
1	Bolsa de Resgate ou caixa de acondicionamento de Primeiros Socorros	1 unidade
2	Kit de prancha longa em polietileno completo	1 unidade
3	Reanimador manual adulto (AMBU)	1 unidade
4	Tesoura sem ponta (tamanho médio)	1 unidade
5	Caixa de luvas (tamanho: M e G)	1 caixa de cada
6	Caixa de máscara descartáveis	1 caixa
7	Manta térmica	1 unidade
8	Óculos de proteção	2 unidades
9	Esparadrapo impermeável	2 unidades
10	Caixa de curativo adesivo (band-aid)	4 unidades
12	Ataduras de crepe de 6 e 10 cm	3 unidades de cada
13	Bandagens triangulares (Tecido de algodão cru -tamanhos P, M e G)	2 unidades de cada tamanho
14	Colar cervical ajustável (Tamanho: P, M e G)	1 unidades de cada
15	Kit de talas moldáveis aramada E.V.A para imobilização de membros	1 unidade
16	Compressa de gazes estéreis (7,5 x 7,5 cm)	20 unidades
17	Antisséptico (Digliconato de Clorexidina)	2 unidades em spray
18	Soro fisiológico 0,9% de 100 ML	10 unidades
19	Saco plástico branco leitoso	3 unidades
20	Termômetro infravermelho	1 unidade
21	Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço	1 unidade
22	Oxímetro de pulso	1 unidade

Caso realize a abertura do soro fisiológico realizar o descarte do mesmo não fazer o reaproveitamento para outro atendimento.

Todo material usado deve ser resposto pela empresa. Os resíduos provenientes do atendimento de saúde referente aos Primeiros Socorros dever ser acondicionado em saco branco leitoso, e o descarte do mesmo deverá ser realizado em qualquer unidade de Saúde da SMS no lixo infectante.

Para a utilização de AMBU e COLAR CERVICAL só pode ser realizado com pessoas treinadas para a utilização do mesmo.

15. TERMO DE COMPROMISSO

Assumo, em nome da Empresa **SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA** o compromisso de seguir as orientações do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), cumprir suas determinações, contribuindo para a realização de todas as medidas preventivas de saúde adotadas:

- 1) Encaminhamento ao Seconci dos trabalhadores da empresa para realização dos exames médicos ocupacionais;
- 2) Acompanhamento de absenteísmo, faltas e seus motivos, informando ao Seconci Goiás os casos pertinentes, para o devido apoio técnico.
- 3) Controle do cumprimento da realização dos exames obrigatórios, conforme normativa legal NR-7, com seus respectivos exames complementares;
- 4) Controle e acompanhamento de todo processo de vacinação de seus trabalhadores;
- 5) Controle e acompanhamento do Planejamento de Ações deste programa.

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Responsável na Empresa pelo Acompanhamento do Programa

16. ANEXOS

QUESTIONÁRIO OMS DE EPILEPSIA

(No Seconci Goiás, o exame é realizado de forma digital pelo Sistema SOC)

Empresa: _____

Nome: _____

Função: _____ **Setor:** _____

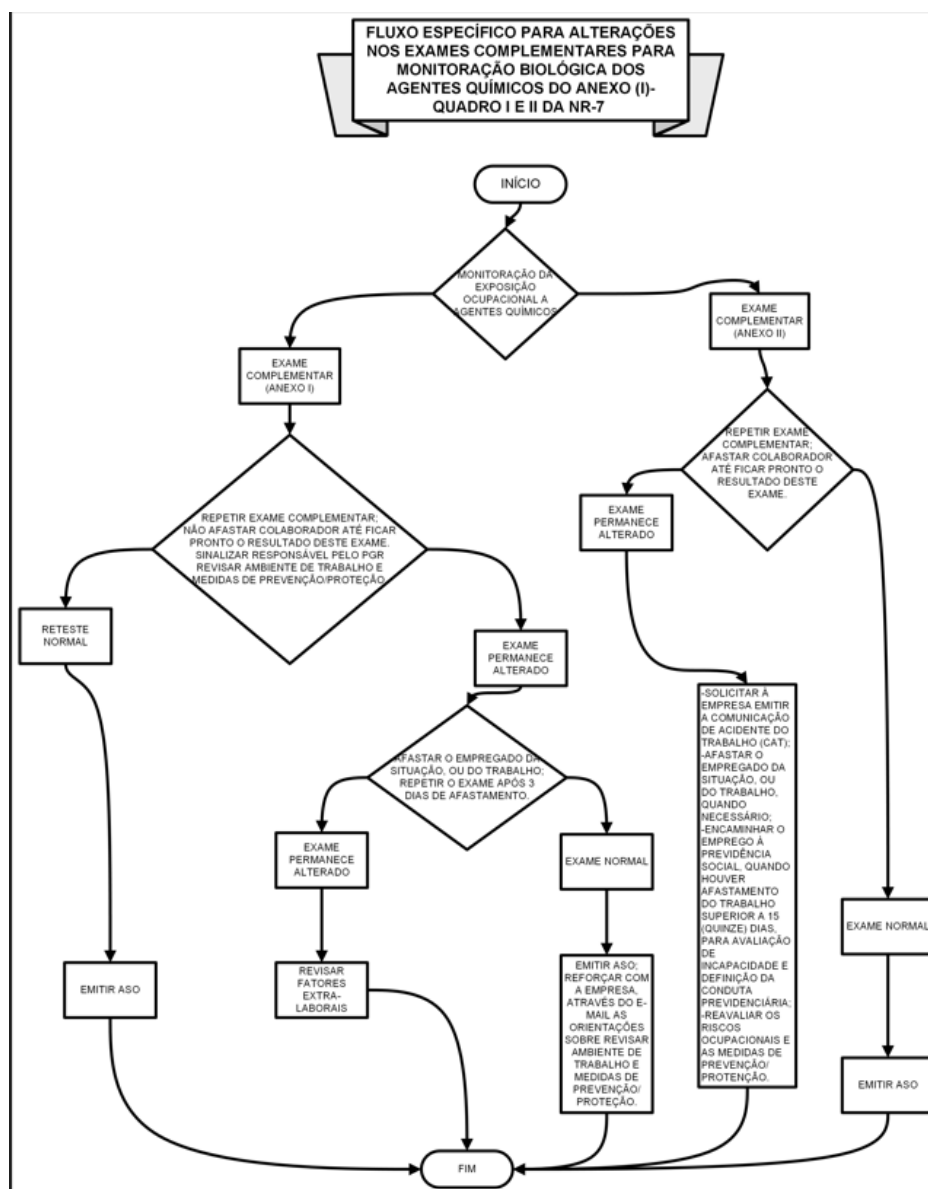
Questionário para identificação de indivíduos com epilepsia (OMS)	
PERGUNTAS	RESPOSTAS
1 - Você tem ou teve crises (ataques, acesso, convulsão) na qual perde a consciência e cai subitamente? E na sua casa, alguém tem?	Sim () Não ()
2 - Você tem ou teve crises em que perde o contato com a realidade (meio) e fica como se estivesse fora do ar? E na sua casa, alguém tem?	Sim () Não ()
3 - Você tem ou teve crises na qual tem repuxões incontroláveis em braços, pernas, na boca ou vira a cabeça para o lado? E na sua casa, alguém tem?	Sim () Não ()
4 - Você tem ou teve crises de desmaio e que ao acordar nota que fez xixi ou cocô na roupa sem perceber? E na sua casa, alguém tem?	Sim () Não ()
5 - Você tem ou teve crises na qual sente sensação ruim de “fundeza” ou bola na “boca do estômago” e que sobe até a garganta e em seguida sai fora do ar, e depois dizem que você ficou mexendo em algo com as mãos ou mastigando ou olhando para algo distante? E na sua casa, alguém tem essas crises?	Sim () Não ()
6 - Algum médico ou profissional de saúde ou mesmo familiares já lhe disse que você tem ou teve convulsão febril na infância; ou durante alguma doença grave qualquer? E na sua casa, alguém teve este problema?	Sim () Não ()
7 - Você tem rápidos abalos tipo “choque” nos braços (as coisas caem da mão) ou pernas, com ou sem queda, principalmente pela manhã?	Sim () Não ()
8 - Há alguém na sua casa com epilepsia em algum asilo?	Sim () Não ()

Data: _____ **Assinatura paciente:** _____

Carimbo e assinatura do Médico: _____

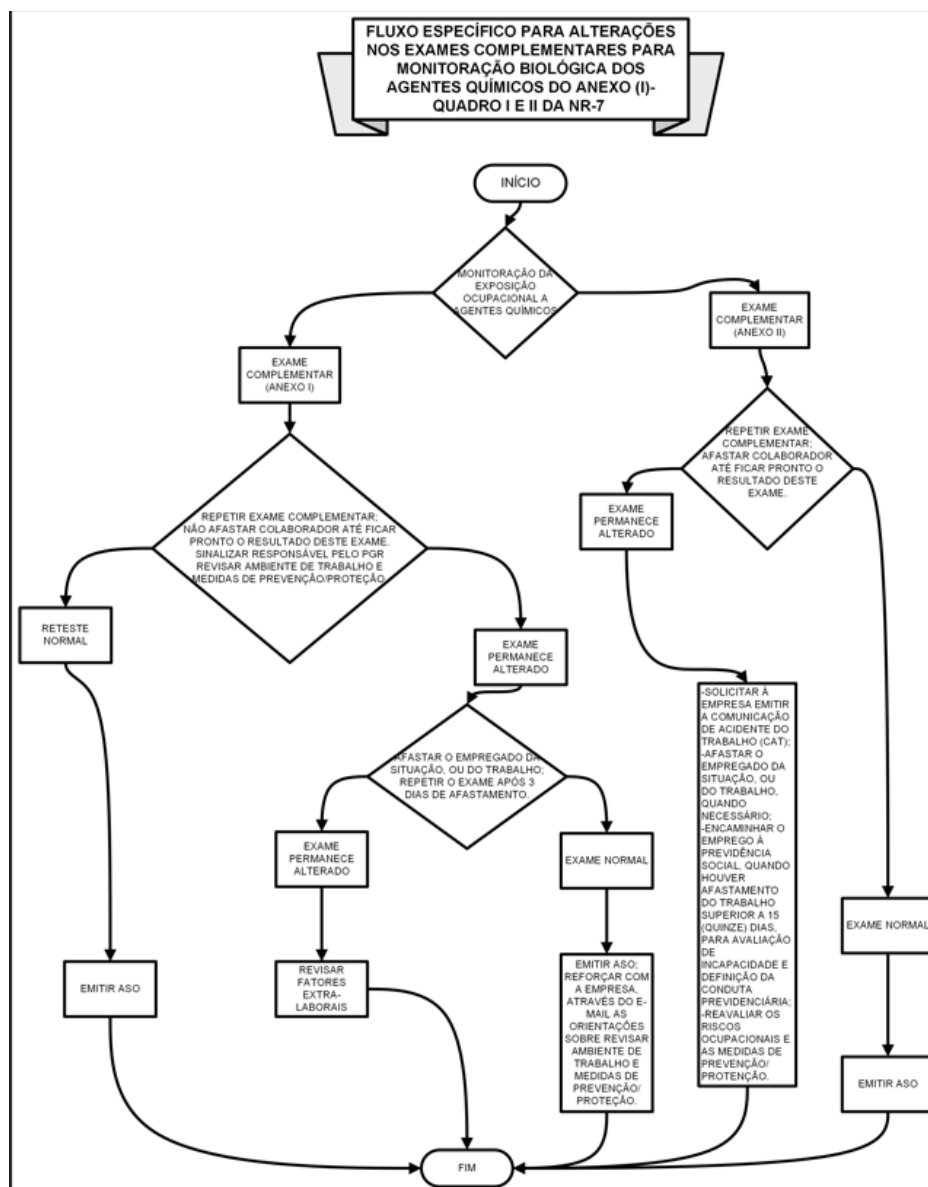
16.1 - ANEXOS

FLUXO GERAL DE SUGESTÃO DE CONDUTAS EM MEDICINA DO TRABALHO



16.2 - ANEXOS

FLUXO ESPECÍFICO PARA ALTERAÇÕES NOS EXAMES COMPLEMENTARES PARA MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA DOS AGENTES QUÍMICOS NO ANEXO I (QUADRO 1 E 2 DA NR-7)



16.3 - ANEXOS

FLUXO ESPECÍFICO PARA ALTERAÇÕES NOS DEMAIS EXAMES COMPLEMENTARES

Acuidade Visual

Exame realizado para avaliação de trabalhadores expostos a atividades críticas (espaço confinado, trabalho em altura, condução de veículos/ máquinas pesadas), como também, para expostos a eletricidade, solda, porteiros, vigias.

Pode-se ter as seguintes conclusões:

- Alteração impede o trabalho - inapto;
- Alteração requer acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho;
- Alteração requer parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral;

Alteração requer restrições indicadas no ASO (trabalho somente em uso de óculos), pelo médico do trabalho/examinador.

Anti-HBs

Exame é realizado, obrigatoriamente, bianual, para avaliação de colaboradores da saúde, expostos a risco ocupacional biológico, como também, para seguir o que está preconizado na NR-32, no item:

"32.2.4.17.3 O empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço."

Exame com títulos abaixo do preconizado são encaminhados para revacinação, e repetir o exame após 60 dias do final do esquema.

Casos em que já foram revacinados e não houve soroconversão, o colaborador é orientado que em um acidente com materiais biológicos, comunicar imediatamente ao Departamento de Saúde ou Segurança do Trabalho da empresa, para agilizar a imunoterapia (imunoglobina).

Anti- HCV Total

Exame é realizado, obrigatoriamente, no admissional e mudança de risco ocupacional, para avaliação de colaboradores da saúde, expostos a risco ocupacional biológico.

Pode-se ter as seguintes conclusões:

- Alteração requer acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho;

Alteração requer parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral.

Audiometria

Exame realizado após 14 horas de repouso acústico, sem sinais e/ou sintomas gripais e/ou otológicos.

Seguir recomendações da NR-07.

- **PAINPSE:**

"5. Interpretação dos resultados dos exames audiométricos

5.1 São considerados dentro dos limites aceitáveis, para efeito deste Anexo, os casos cujos audiogramas mostram limiares auditivos menores ou iguais a 25 (vinte e cinco) dB (NA) em todas as frequências examinadas.

5.2 São considerados sugestivos de Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados (PAINPSE) os casos cujos audiogramas, nas frequências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentem limiares auditivos acima de 25 (vinte e cinco) dB (NA) e mais elevados do que nas outras frequências testadas, estando estas comprometidas ou não, tanto no teste da via aérea quanto da via óssea, em um ou em ambos os lados.

5.2.1 Não são consideradas alterações sugestivas de PAINPSE aquelas que não se enquadrem nos critérios definidos no item 5.2 acima.

5.3 São considerados sugestivos de desencadeamento de PAINPSE os casos em que os limiares auditivos em todas as frequências testadas no exame audiométrico de referência e no sequencial permaneçam menores ou iguais a 25 (vinte e cinco) dB (NA), mas a comparação do audiograma sequencial com o de referência mostra evolução que preencha um dos critérios abaixo:

a) a diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 (dez) dB (NA);

b) a piora em pelo menos uma das frequências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 15 (quinze) dB (NA).

5.3.1 São considerados sugestivos de agravamento da PAINPSE os casos já confirmados em exame audiométrico de referência e nos quais a comparação de exame audiométrico sequencial com o de referência mostra evolução que preenche um dos critérios abaixo:

a) a diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo de frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz, ou no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 (dez) dB (NA);

b) a piora em uma frequência isolada iguala ou ultrapassa 15 (quinze) dB (NA).

5.5.1 O exame audiométrico sequencial que venha a demonstrar desencadeamento ou agravamento de PAINPSE passará a ser, a partir de então, o novo exame audiométrico de referência.

6. O diagnóstico conclusivo, o diagnóstico diferencial e a definição da aptidão para a função ou atividade, na suspeita de PAINPSE, são atribuições do médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

7. Devem ser motivo de especial atenção empregados expostos a substâncias ototóxicas e/ou vibração, de forma isolada ou simultânea à exposição a ruído potencialmente nocivo à audição.

8. A PAINPSE, por si só, não é indicativa de inaptidão para o trabalho, devendo-se levar em consideração na análise de cada caso, além do traçado audiométrico ou da evolução sequencial de exames audiométricos, os seguintes fatores:

a) a história clínica e ocupacional do empregado;

b) o resultado da otoscopia e de outros testes audiológicos complementares;

c) a idade do empregado;

d) os tempos de exposição pregressa e atual a níveis de pressão sonora elevados;

e) os níveis de pressão sonora a que o empregado estará, está ou esteve exposto no exercício do trabalho;

f) a demanda auditiva do trabalho ou da função;

g) a exposição não ocupacional a níveis de pressão sonora elevados;

h) a exposição ocupacional a outro(s) agente(s) de risco ao sistema auditivo;

i) a exposição não ocupacional a outro(s) agentes de risco ao sistema auditivo;

j) a capacitação profissional do empregado examinado;

k) os programas de conservação auditiva aos quais tem ou terá acesso o empregado.

9. Nos casos de desencadeamento ou agravamento de PAINPSE, conforme os critérios deste anexo, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve:

a) definir a aptidão do empregado para a função;

- b) incluir o caso no Relatório Analítico do PCMSO;
c) participar da implantação, aprimoramento e controle de programas que visem à conservação auditiva e prevenção da progressão da perda auditiva do empregado acometido e de outros expostos a riscos ocupacionais à audição, levando-se em consideração, inclusive, a exposição à vibração e a agentes ototóxicos ocupacionais;
d) disponibilizar cópias dos exames audiométricos aos empregados."

- Alterações não sugestivas de PAINPSE:

"10. Nos casos em que o exame audiométrico de referência demonstre alterações cuja evolução esteja em desacordo com os moldes definidos neste Anexo para PAINPSE, o médico o trabalho responsável pelo PCMSO deve:

- a) verificar a possibilidade da presença concomitante de mais de um tipo de agressão ao sistema auditivo;
b) orientar e encaminhar o empregado para avaliação especializada;
c) definir sobre a aptidão do empregado para função;
d) participar da implantação e aprimoramento de programas que visem à conservação auditiva e prevenção da progressão da perda auditiva do empregado acometido e de outros expostos a riscos ocupacionais à audição, levando-se em consideração, inclusive, a exposição à vibração e a agentes ototóxicos ocupacionais;
e) disponibilizar cópias dos exames audiométricos aos empregados".

Avaliar capacidade laboral conforme riscos ocupacionais, encaminhar ao médico especialista para avaliação e tratamento caso necessário.

Avaliação Psicossocial

Exame é realizado, obrigatoriamente, para avaliação de colaboradores expostos ao risco ocupacional de espaço confinado. Nas demais avaliações, se após exame clínico médico ocupacional for verificado algum fator psicossocial, tanto na anamnese quanto exame físico, que deva ser melhor investigado através desta avaliação.

Pode-se ter as seguintes conclusões:

- Alteração impede o trabalho - inapto;
- Alteração requer acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho;
- Alteração requer parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral;

Alteração requer restrições indicadas no ASO pelo médico do trabalho/examinador.

Coprocultura

Exame realizado para colaboradores manipuladores de alimento.

Em casos de alterações, avaliar e definir etiologia da patologia.

Caso necessário, em infecções infectocontagiosas, pelo risco de transmissão a terceiros, afastar e tratar ou encaminhar para o médico especialista.

EAS (exame de urina)

Exame realizado para colaboradores manipuladores de alimento.

Em casos de alterações, avaliar e definir etiologia da patologia.

Caso necessário, em infecções infectocontagiosas, pelo risco de transmissão a terceiros, afastar e tratar ou encaminhar para o médico especialista.

Eletrocardiograma

Nos pacientes jovens (menor ou igual a 40 anos), hígido, assintomático, avaliar clinicamente o trabalhador em relação aos achados X sintomas X resultado.

Pode-se ter as seguintes conclusões:

- Alteração impede o trabalho - inapto;
- Alteração requer acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho;
- Alteração requer parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral;
- Alteração requer restrições indicadas no ASO, pelo médico do trabalho/examinador.

Por sua vez, trabalhadores com comorbidades (Obesidade, HAS, DM, dislipidemia, doença de chagas, uso de medicações psiquiátricas), sintomáticos ou maiores de 40 anos deverão ser encaminhados ao cardiologista.

EPF/ Coproparasitológico

Exame realizado para colaboradores manipuladores de alimento.

Em casos de alterações, avaliar e definir etiologia da patologia.

Caso necessário, em infecções infectocontagiosas, pelo risco de transmissão a terceiros, afastar e tratar ou encaminhar para o médico especialista.

Espirometria:

Realizar diagnóstico diferencial e, se necessário, afastar e tratar ou encaminhar para o médico especialista. Avaliar e definir etiologia da patologia.

Alterações leves e pontuais, em assintomáticos, sem histórico de doenças e/ou prévias, requerem acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho.

Demais alterações requerem parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral.

Em caso de doença ocupacional, orientar a empresa a emitir a CAT, Notificação Compulsória e informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção/ proteção.

Exame Clínico:

Consiste em anamnese, história da doença atual e pregressa, familiar, psicossocial, laboral, acompanhados do exame físico e mental.

As informações são registradas no prontuário médico.

Após esta avaliação, poderá resultar nas seguintes conclusões.

Todos exames estejam normais: o ASO será liberado como apto - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) apto: paciente liberado para exercer a função;

Alguma alteração nos exames: colaborador é informado da alteração, bem como o significado das alterações e as condutas necessárias para acompanhar, tratar e/ou curar o quadro.

Alteração impede o trabalho - inapto;

Alteração requer acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho;

Alteração requer parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral;

Alteração requer restrições indicadas no ASO, pelo médico do trabalho/examinador.

Glicemia de jejum

Exame realizado para avaliação de trabalhadores expostos a atividades críticas (espaço confinado, trabalho em altura, condução de veículos/ máquinas pesadas).

No exame alterado, deve-se investigar patologias como Diabetes 1 ou 2, hipoglicemia, bem como formas de tratamento, insulinodependência, uso de hipoglicemiantes orais e dieta.

Avaliar e definir etiologia da patologia.

Orientar paciente em relação à mudança de estilo de vida, necessidade de tratamento, se o caso, como também, uso correto e regular de medicações, quando necessário.

Pode-se ter as seguintes conclusões:

Alteração impede o trabalho - inapto;

Alteração requer acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho;

Alteração requer parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral;

Alteração requer restrições indicadas no ASO, pelo médico do trabalho/examinador.

HBsAg

Exame é realizado, obrigatoriamente, no admissional e mudança de risco ocupacional, para avaliação de colaboradores da saúde, expostos a risco ocupacional biológico.

Pode-se ter as seguintes conclusões:

Alteração requer acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho;

Alteração requer parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral.

Hemograma Completo

Exame realizado para avaliação de trabalhadores expostos a atividades críticas (espaço confinado, trabalho em altura, condução de veículos/ máquinas pesadas), como também, para expostos a forma direta/indireta à Benzeno, radiações ionizantes, trabalhadores da saúde e manipuladores de alimentos.

Pode haver a anormalidade quantitativas (anemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia) e/ ou qualitativas (forma e função das células, como macrocitose, microcitose, pontilhado basófilo, macro plaquetas).

Realizar diagnóstico diferencial e, se necessário, afastar e tratar ou encaminhar para o médico especialista. Avaliar e definir etiologia da patologia.

Alterações leves e pontuais, em assintomáticos, sem histórico de doenças e/ou prévias, requerem acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho.

Demais alterações requerem parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral.

Em caso de doença ocupacional, orientar a empresa a emitir a CAT e Notificação Compulsória e informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos iscos ocupacionais e das medidas de prevenção/ proteção.

Micológico de Unhas

Exame realizado para colaboradores manipuladores de alimento.

Em casos de alterações, avaliar e definir etiologia da patologia.

Caso necessário, de infecções infectocontagiosas, pelo risco de transmissão a terceiros, afastar e tratar ou encaminhar para o médico especialista.

Rx de Coluna Total

Realizado do admissional ou mudança de risco ocupacional para colaboradores expostos a vibração de corpo inteiro.

Tem como objetivo acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais.

Pode-se ter as seguintes conclusões:

Alteração impede o trabalho - inapto;

Alteração requer acompanhamento com mais atenção pela medicina ocupacional e/ou médico assistente especialista, mas não o incapacita para o trabalho;

Alteração requer parecer de especialista para julgamento da capacidade laboral;

Alteração requer restrições indicadas no ASO.

Rx de Tórax OIT

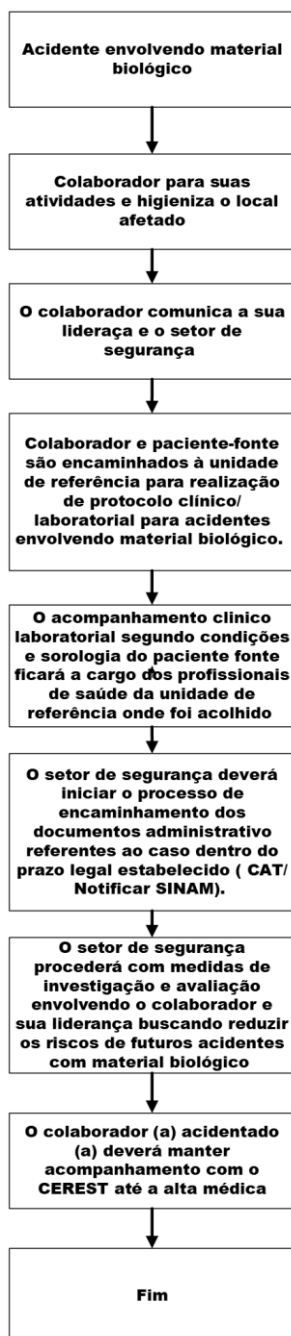
No caso de alterações: solicitar parecer de pneumologista, exceto se a alteração for granuloma. Neste caso, orientar paciente frente a alteração e formas de cuidados e acompanhamento.

Realizar diagnóstico diferencial e, se necessário, afastar e tratar ou encaminhar para o médico especialista. Avaliar e definir etiologia da patologia.

Em caso de doença ocupacional, avaliar todos os trabalhadores do setor para identificar precocemente outros possíveis casos, orientar a empresa a emitir a CAT e Notificação Compulsória e informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos iscos ocupacionais e das medidas de prevenção/ proteção.

16.4 - ANEXOS

Fluxograma para Acidente de Trabalho com Materiais Biológicos



Patrícia Montalvo Moraes
Médico responsável pelo PCMSO
CRM: 14949/GO
Especialidade: Medicina do Trabalho
RQE: 9.662